MENOPAUSIA

sin tabú



60 PÁGINAS · 10 CAPÍTULOS

10 HERRAMIENTAS PARA HOY

CADA DATO CON SU FUENTE

DENTRO

Calores, sueño, ánimo, huesos, corazón y deseo. Qué es real, qué dice la evidencia y cómo armar tu propio plan.

Lo que nadie te explicó.

Con empatía y responsabilidad.

48,6 años: edad mediana en Latinoamérica*

*Palacios et al., estudio REDLINC, 17.150 mujeres de 15 países, revista Menopause, 2006.

LÉELO PRIMERO

hola

Un libro honesto sobre un tema que lo merece

Aquí no hay milagros ni miedo. Hay datos con su fuente, herramientas para usar hoy y palabras para pedir lo que necesitas.

AVISO MÉDICO

Este manual informa y acompaña. No diagnostica ni sustituye a tu profesional de salud. No empieces, cambies ni dejes un medicamento sin evaluación médica.

¿Sangrado tras la menopausia? Consulta pronto. ¿Pensamientos de hacerte daño? Busca ayuda urgente hoy (pág. 44).

CÓMO SE HIZO

Cada cifra viene de una fuente identificable: OMS, CDC, NIH, NICE, NHS, The Menopause Society, *The Lancet* y estudios revisados. Las fuentes van bajo cada gráfico y, completas, en las págs. 58–59. Consultadas en octubre de 2026.

LAS CIFRAS

Muchos datos vienen de EE. UU. o Europa, y lo indicamos. Si hay datos de Latinoamérica, van primero. Cálculos propios y ejemplos están marcados. Sin testimonios inventados ni promesas.

LAS IMÁGENES

Las fotos son ilustraciones generadas con IA (Higgsfield Soul 2.0). No son personas reales ni pacientes. Hablamos de «mujeres», pero todo aplica a cualquier persona que viva la menopausia.

Cómo está hecho cada capítulo

- **La idea clave:** una frase para recordar.
- **Herramienta:** checklist, guion o plantilla.
- **FIG.:** gráficos con su fuente debajo.
- **Para compartir:** páginas para quien te acompaña.



PAUSA — El manual de la menopausia. Primera edición, octubre de 2026.
© 2026 DisierTECH. Todos los derechos reservados. Uso personal: puedes imprimir las plantillas para ti.

querida,

Nadie debería atravesar esto a ciegas.



Durante años, la menopausia se dijo en voz baja: «son cosas de la edad», «aguanta». Mientras, millones de mujeres vivían calores, noches sin dormir y cambios de ánimo que no reconocían como propios.

Este manual parte de algo simple: **entender es la primera forma de cuidarse**.

Dos palabras lo guían. **Empatía**, porque lo que sientes es real. **Responsabilidad**, porque cuidarte también es tarea de tu pareja, tu familia, tu equipo de salud y tu trabajo.

con cariño, **el equipo de PAUSA**

EL BRIEF EN 3 FRASES

A — PARA QUIÉN

Mujeres de 40 a 60 que notan cambios, o ya viven la menopausia, y quieren entenderlos sin miedo.

B — EL PROBLEMA

Síntomas reales, poca información clara, consultas cortas y un entorno que minimiza.

C — LA PROMESA

En 10 capítulos entenderás tu cuerpo, llegarás a tu consulta con datos y armarás un plan propio, con apoyo.

45%
no conocía la diferencia entre perimenopausia y menopausia antes de vivirla.

20%
esperó 12 meses o más a una evaluación médica formal.

Fuente: Bonafide, *State of Menopause Survey*, citada en SWHR, *Menopause Fact Sheet*, feb. 2025 (EE. UU.).

CÓMO USAR ESTE MANUAL

Parte I para entender. **Parte II** para actuar. **Parte III** para compartir. Cada capítulo abre con una idea clave y cierra con una herramienta.

Importante. Este manual informa y acompaña; no reemplaza la consulta. Ninguna decisión sobre medicamentos sin evaluación médica.

Sumario *tu ruta*

PARTE I · ENTENDER 06

01 **Qué es (y qué no es)** — Etapas, hormonas, tipos y anticoncepción. 07

02 **Los síntomas, sin tabú** — Calores, zona íntima, sueño, ánimo y cuerpo. 11

03 **Lo que no se ve** — Huesos, corazón, mente y chequeos. 16

PARTE II · ACTUAR 20

04 **Tu diario de síntomas** — Cuatro semanas que cambian tu consulta. 21

05 **La consulta que mereces** — El guion, y qué hacer si no te escuchan. 25

06 **Tratamientos con evidencia** — Hormonales y no hormonales, sin miedo. 29

07 **Cuerpo en movimiento** — Fuerza, comida y sueño. 35

PARTE III · COMPARTIR 40

08 **La empatía empieza por ti** — Autocompasión, deseo y señales de alarma. 41

09 **Responsabilidad compartida** — Pareja, familia, trabajo y empresas. 45

10 **Mitos y preguntas** — Diez mitos y las dudas de siempre. 51

EMPIEZA AQUÍ · 55 **PLAN 30 DÍAS · 56** **GLOSARIO · 57**

FUENTES · 58



CAP. 07 · PÁG. 35



CAP. 09 · PÁG. 46

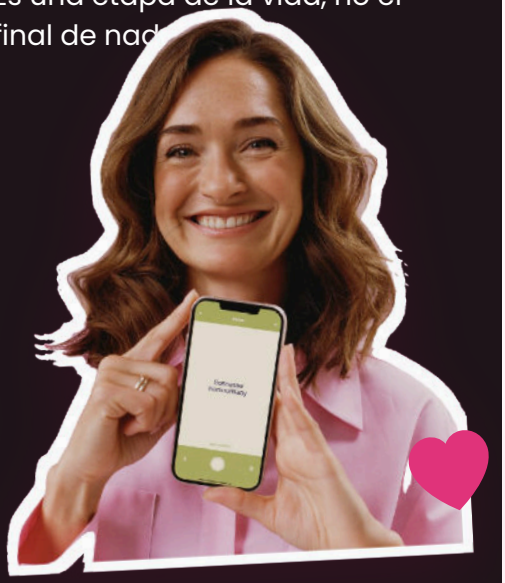
10 HERRAMIENTAS

Una por capítulo. Índice completo en la pág. 05.

manifiesto

Diez ideas que cambian todo

1. Lo que sientes es real, aunque nadie lo vea.
2. No es una enfermedad, pero sus síntomas sí se tratan.
3. Medir es la mejor forma de ser escuchada.
4. Ninguna opción es buena para todas: es buena o no para ti.
5. Huesos, corazón y ánimo merecen atención aunque no duelan.
6. La fuerza es cuidado, no estética.
7. Pedir ayuda no es exagerar.
8. Tu bienestar también es tarea de tu entorno.
9. Hablarlo en voz alta quita poder al tabú.
10. Es una etapa de la vida, no el final de nad



ÍNDICE DE HERRAMIENTAS

Para usar, imprimir y compartir

01 **¿En qué etapa estoy?** Checklist según el consenso STRAW+10. 07

02 **Mapa de síntomas** Marca y puntúa de 0 a 3. 12

03 **Tabla de chequeos** Qué revisar en consulta. 19

04 **Diario de 4 semanas** Para llenar y llevar. 22

05 **Guion de consulta** Las preguntas que no pueden faltar. 26

06 **Tu mesa de decisión** Compara opciones con tu profesional. 34

07 **Tu semana** Fuerza, movimiento y sueño. 39

08 **Señales de alarma** Cuándo consultar y cuándo es urgente. 44

09 **En el trabajo** Guion para tu jefe y ajustes. 49

10 **Respuestas claras** Preguntas frecuentes. 54

INCLUIDA EN EL PACK · TU APP

Registra tus síntomas cada día, mira tu progreso y llévalo a la consulta. Guarda tu historial en el celular y el computador.

menopausia-equilibrada.vercel.app/#hoy

PARTE I

Entender

I

Tu cuerpo no se está rompiendo: está cambiando. Antes de decidir nada, conviene saber qué cambia, cuándo y por qué.



EN ESTA PARTE

01 Qué es (y qué no es)

02 Los síntomas, sin tabú

03 Lo que no se ve

26%

de todas las mujeres y niñas del mundo tenían 50 años o más en 2021 (22% diez años antes). Una cuarta parte: no es un tema de nicho.

Fuente: OMS, nota descriptiva «Menopausia», 16 oct. 2024.

CAPÍTULO 01

Qué es *(y qué no es)* 01

IDEA CLAVE

La menopausia es un momento —12 meses sin regla—; lo que más se siente es el camino hacia ella.

Etapa reproductiva
Ciclos regulares.

Perimenopausia
Temprana: ciclos que varían 7+ días. Tardía: 60+ días sin regla (1–3 años).

Última regla

Posmenopausia
Empieza tras la última regla; se confirma a los 12 meses.

FIG. 02 · Etapas según el consenso STRAW+10. Harlow et al., Menopause, 2012; resumen en Manual MSD.

La menopausia natural se confirma tras **12 meses seguidos sin regla**, sin otra causa. Lo que más se vive es la **perimenopausia**: los años de ciclos irregulares y primeros síntomas.

La mayoría llega entre los **45 y 55 años** (OMS). En Latinoamérica, el estudio REDLINC halló una mediana de **48,6 años**.

Antes de los 40 es prematura; de 40 a 44, temprana. Merecen evaluación propia (pág. 09).

Lo que no es: ni una enfermedad ni el final de tu vida sexual, laboral o creativa. A los 60 quedan, en promedio, unos 21 años de vida (OMS).

HERRAMIENTA 01

¿En qué etapa estoy?

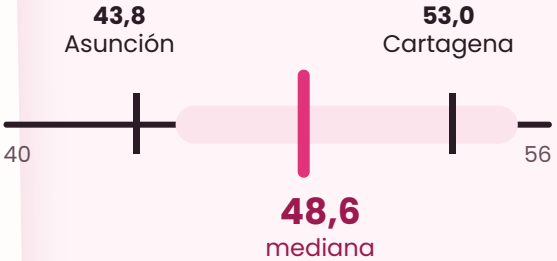
- ☐ Mis ciclos varían **7 días o más**, de forma persistente.
- ☐ He pasado **60 días o más** sin regla.
- ☐ Llevo **12 meses** seguidos sin regla.
- ☐ Tengo **menos de 45** y noto cambios: pide evaluación.

Con anticonceptivos hormonales, DIU hormonal o tras histerectomía, el ciclo no sirve de guía: consúltalo.



FIG. 03 · EDAD MEDIANA

en Latinoamérica



Franja rosada: 45–55 años (OMS). Palacios et al., REDLINC, 17.150 mujeres, Menopause, 2006; OMS, oct. 2024.

Ojo: en la perimenopausia aún puedes quedar embarazada. Anticoncepción: pág. 10.

01 · CONTINUACIÓN

hormonas

Lo que pasa por dentro

No hace falta saber de endocrinología. Basta con conocer a tres protagonistas y cómo cambia su conversación.

Estrógeno

Lo producen sobre todo los ovarios. En la perimenopausia sube y baja sin orden; tras la última regla queda bajo. De ahí vienen muchos síntomas: calores, sequedad, sueño.

Progesterona

Aparece tras la ovulación. Cuando los ciclos dejan de ovular, baja antes. Por eso lo primero que cambia suele ser la regla: más corta, más larga, más o menos abundante.

FSH

Es la señal del cerebro al ovario. Si el ovario responde menos, el cerebro «insiste» y la FSH sube, pero de forma variable: un solo análisis puede salir normal en plena transición.

Fuentes: consenso STRAW+10 (Harlow et al., Menopause, 2012), resumen en Manual MSD; NHS, «Menopause: symptoms», may. 2026.

¿Necesito un análisis de sangre?

Lo que recomienda la guía NICE (Reino Unido):

45+	Se diagnostica por los síntomas y el patrón de la regla, sin laboratorio.
40–45	Puede considerarse una prueba de FSH si hay síntomas y cambios en el ciclo.
<40	Se sospecha insuficiencia ovárica prematura: FSH alta en dos análisis con 4–6 semanas de diferencia.
Con píldora	La FSH no sirve si usas anticoncepción combinada o progestágeno en dosis altas.

Fuente: NICE, guía NG23, recomendaciones de diagnóstico. Los criterios pueden variar en tu país.



tus síntomas cuentan

Con más de 45, lo que sientes y cómo cambia tu regla dicen más que un análisis aislado.

01 · CONTINUACIÓN

No todas llegan por el mismo camino

La natural es la más frecuente, pero no la única. Saber cuál es la tuya cambia qué vigilar y qué preguntar.



A

Natural

Los ovarios bajan su actividad poco a poco. La mayoría la vive entre los 45 y 55.

B

Temprana o prematura

Antes de los 45 o de los 40 (insuficiencia ovárica prematura, IOP). Más riesgo cardiovascular y de osteoporosis.

C

Quirúrgica

Si se extraen ambos ovarios. El cambio es inmediato y suele traer más síntomas. Pide un plan antes de la cirugía.

D

Por tratamientos

Quimio, radioterapia o algunos medicamentos. Tu equipo de oncología debe estar en la conversación.

~4%
con IOP (antes de los 40)

~12%
con menopausia temprana (40–45)

Estimaciones de una revisión de 2026. La serie de The Lancet (2024) habla de cerca del 10% para ambas juntas: las cifras varían según el estudio.

Fuentes: OMS, oct. 2024; Jean Hailes for Women's Health, «Causes of menopause»; revisión sobre IOP, Australian Journal of General Practice, abr. 2026 (guía ESHRE/ASRM/IMS 2024).

¿Te pasa antes de los 45? Pregunta:

- ¿Qué estudios necesito para confirmar la causa?
- ¿Cómo cuidamos mis huesos y mi corazón desde ahora?
- ¿Me conviene terapia hormonal hasta la edad habitual de la menopausia?*
- ¿Con quién hablo del impacto emocional o la fertilidad?

*La guía internacional de 2024 recomienda terapia hormonal en la IOP salvo contraindicación, hasta cerca de los 51 años. ¿Sin útero pero con ovarios? Lleva un diario de síntomas 3 meses (Jean Hailes).

Sí.

01 · CONTINUACIÓN

¿Todavía puedo quedar embarazada?

En la perimenopausia los ciclos son irregulares, pero aún puede haber ovulaciones. Un embarazo es **menos probable, no imposible**.

Si no lo buscas, la anticoncepción sigue en el plan. Con anticoncepción hormonal, la regla deja de ser guía de tu etapa: decide cuándo suspenderla con tu profesional.

FIG. 12 · CUÁNTO MANTENERLA
desde tu última regla

De 40 a 50	2 años
Más de 50	1 año

EMAS, Menopause Essentials 2026: Contraception (remite a la guía FSRH). Ojo: la concepción a finales de los 50 es rara pero documentada; con IOP puede haber ovulaciones ocasionales.

SANGRADO DESPUÉS DE LA MENOPAUSIA

una gota también cuenta

Si pasaste 12 meses sin regla y vuelves a sangrar, consulta. Casi siempre la causa es benigna (tejido más fino, pólipos). Rara vez es cáncer, y por eso conviene revisarlo pronto: a tiempo, se trata mejor.

HERRAMIENTA · PIDE CITA SI…

- [ ] sangras tras 12 meses sin regla, aunque sea poco;
- [ ] ves manchado rosado o marrón;
- [ ] pasó una sola vez, sin otros síntomas;
- [ ] no estás segura de si es sangre.

Fuente: HSE (Irlanda), «Postmenopausal bleeding».



Anota fecha, cantidad y color

En la perimenopausia el sangrado puede cambiar: más abundante o más escaso. Si te preocupa, regístralo en la app y llévalo a tu consulta: menopausia-equilibrada.vercel.app/#hoy

CAPÍTULO 02

Los síntomas, *sin tabú*

02

IDEA CLAVE

Si lo sientes, cuenta. Casi la mitad de las mujeres de 40 a 60 tuvo síntomas el último año, y muy pocas reciben tratamiento.

49,4%
de las mujeres de 40 a 60 tuvo síntomas en los últimos 12 meses (EE. UU., 2025).

15,6%
de ellas tomaba medicación con receta para esos síntomas: menos de 1 de cada 6.

7,4 años
duración mediana de los calores frecuentes (estudio SWAN).

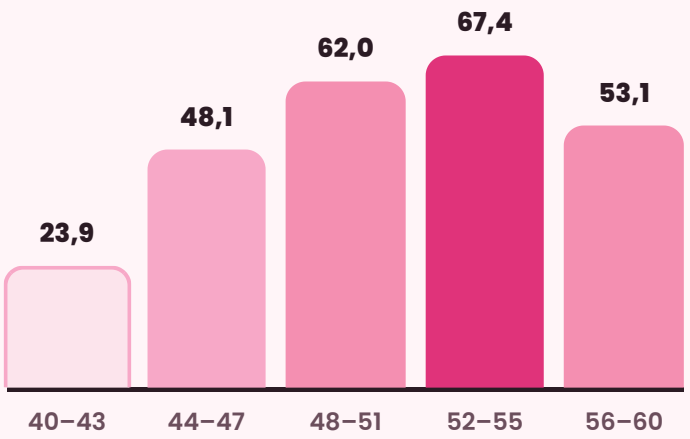
Fuentes: CDC/NCHS, Data Brief n.º 575, oct. 2026; Avis et al., JAMA Internal Medicine, 2015 (1.449 mujeres).

Los **calores** (sofocos) son una ola de calor en pecho, cuello y cara, a veces con sudor, que dura minutos. De noche se vuelven **sudores nocturnos** y cortan el sueño.

No es falta de carácter: el «termostato» del cerebro se vuelve más sensible cuando bajan los estrógenos.

En SWAN duraron 4,5 años tras la última regla (mediana). En mujeres hispanas, la duración total fue de **8,9 años**. «Ya se te pasará» no es un plan.

FIG. 04 · CON SÍNTOMAS, POR EDAD (%)



Años de edad. Pico entre los 52 y 55: 2 de cada 3. Fuente: CDC/NCHS, Data Brief n.º 575 (EE. UU., 2025).



Dormir mal no es un defecto de carácter: los sudores nocturnos son un síntoma, y tienen tratamiento.

El insomnio está entre los síntomas que reconoce la OMS. Anótalo en tu diario (cap. 04).

02 · CONTINUACIÓN

íntimo

El síntoma del que menos se habla

Sequedad, ardor, dolor en las relaciones, urgencia para orinar o infecciones repetidas: es el **síndrome genitourinario de la menopausia** (SGM).

En una encuesta a 1.858 mujeres con estos síntomas, **la mitad nunca había usado tratamiento** y casi 3 de cada 4 de ellas no lo había comentado con un profesional. Tiende a aumentar con los años, y tiene tratamientos eficaces a cualquier edad (cap. 06).

27–84%

de las mujeres posmenopáusicas vive el SGM, según los estudios.

The Menopause Society, declaración sobre SGM, 2020.

FIG. 06 · AÑOS DE CALORES



Medianas, estudio SWAN. Avis et al., JAMA Intern Med, 2015.

HERRAMIENTA 02 **Mapa de síntomas**

Marca y anota intensidad: 1 leve · 2 media · 3 fuerte

TEMPERATURA

- ☐ Calores / sofocos ☐
- ☐ Sudores nocturnos ☐

CICLO

- ☐ Reglas irregulares ☐
- ☐ Flujo distinto ☐

SUEÑO

- ☐ Me cuesta dormirme ☐
- ☐ Despierto de noche ☐

ÁNIMO

- ☐ Irritabilidad ☐
- ☐ Tristeza persistente ☐
- ☐ Ansiedad ☐

ZONA ÍNTIMA

- ☐ Sequedad vaginal ☐
- ☐ Dolor en relaciones ☐
- ☐ Escapes / urgencia ☐

CUERPO

- ☐ Más grasa abdominal ☐
- ☐ Menos fuerza ☐

Basado en los síntomas que describe la OMS (2024) y los cambios corporales de la American Heart Association (2020). No es un diagnóstico. También puedes llevarlo en la app: menopausia-equilibrada.vercel.app/#hoy

Nombrarlo es el primer paso.

La sequedad o el dolor no son algo que «hay que aguantar». Lleva este mapa a tu consulta: el guion de la pág. 26 te ayuda a pedirlo con calma.



02 · CONTINUACIÓN

Cuando la noche se vuelve *larga*



Sudores nocturnos, ansiedad o ánimo bajo rompen el sueño. Y dormir mal trae irritabilidad y estrés (NHS). Se puede romper el círculo.

1 de 3
mujeres en la transición tenía insomnio con criterios clínicos (SWAN).

41%
de las posmenopáusicas de SWAN se despertaba con frecuencia de noche.

Fuentes: SWAN, 3.302 mujeres, NAMS 2015 (MDedge, oct. 2015); Kravitz et al., SWAN, Sleep, 2008 (ScienceDaily); NHS, «Menopause: symptoms», may. 2026.

FIG. 14 · LO QUE TIENE EVIDENCIA

La **terapia cognitivo-conductual** (TCC) puede usarse para calores y sudores, y además reducir el estrés y mejorar sueño y ánimo (serie de *The Lancet*, 2024). Para el insomnio, el NHS la ofrece en persona o en línea.

Si los sudores son la causa principal, tratar los calores (cap. 06) suele ser el camino más directo.

CONSULTA SI…
los cambios no ayudan, llevas meses durmiendo mal o el cansancio te frena el día. Es motivo de consulta, no un capricho.

Fuente: NHS, «Insomnia», mar. 2024.

HERRAMIENTA

6 hábitos para esta semana

- **Misma hora de levantarte**
  Todos los días, también tras una mala noche.
- **A la cama con sueño**
  No antes. Y una hora de calma previa.
- **Cuarto oscuro y fresco**
  Silencio y ropa de cama cómoda.
- **Café, té y alcohol: no 6 h antes**
  Ni cenas copiosas tarde.
- **Pantallas lejos de la cama**
  TV y móvil fuera antes de dormir.
- **Muévete de día**
  Ejercicio regular, no en las 4 h previas. Sin siestas.

Adaptado de los consejos de autocuidado del NHS, «Insomnia».

02 · CONTINUACIÓN

No es tu carácter: también es tu biología

Cambios de humor, irritabilidad, ansiedad, ánimo bajo y «niebla mental» (memoria, concentración) están entre los síntomas que describe el NHS. No eres exagerada.



nombrarlo ya alivia

+40%

más riesgo de síntomas depresivos o depresión en la perimenopausia que antes de ella.

Badawy et al., metaanálisis de 7 estudios y 9.141 mujeres, J. Affective Disorders, may. 2024 (UCL).

MATIZ IMPORTANTE

La menopausia no suele causar sola problemas de salud mental. El riesgo sube con calores intensos, depresión previa o estrés reciente. Y la terapia hormonal alivia los calores, pero **no trata la depresión** (*The Lancet*, 2024).

FIG. 16 · ¿Y LA MEMORIA? UN BACHE TEMPORAL

Mejora de la memoria verbal con la práctica (premenopausia = 100):



Después de la menopausia, el aprendizaje volvió a niveles previos. Estudio de 2.362 mujeres de 42 a 52 años, Neurology, 2009 (American Academy of Neurology).

HERRAMIENTA

Termómetro de la semana

Marca los días en que lo notaste

	L	M	X	J	V	S	D
Ánimo bajo	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Ansiedad	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Irritabilidad	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Niebla mental	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Calores	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Mal descanso	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

¿Ánimo bajo casi a diario 2 semanas o más? Coméntalo con un profesional (OMS). Si piensas en hacerte daño, busca ayuda de inmediato (pág. 44).

02 · CONTINUACIÓN

Un cuerpo que se reorganiza

¿La ropa te queda distinta sin haber cambiado nada? No es falta de voluntad: la grasa tiende a ir al abdomen y se pierde músculo, aun con el mismo peso.

1. **Grasa abdominal**
   Aumenta la grasa central; se asocia a más riesgo cardiovascular incluso con peso normal.
2. **Menos músculo**
   Baja la masa magra: menos fuerza y otro metabolismo.
3. **Articulaciones y músculos**
   Dolores musculares y articulares, entre los síntomas descritos.
4. **Piel, cabello y más**
   Piel seca o con picor, cabello más fino, palpitaciones, dolores de cabeza, encías sensibles.

Fuentes: 1–2, American Heart Association, 2020 (resumen ACC); 3–4, NHS, «Menopause: symptoms», may. 2026.



tu aliado

7%
de las mujeres en la perimenopausia cumple las recomendaciones de actividad física.

<20%
mantiene una alimentación saludable en esa etapa.

LA BUENA NOTICIA

Los ensayos sugieren que cambios de estilo de vida durante la transición pueden prevenir el aumento de peso. **No es tarde: es el momento.**

Fuente: El Khoudary et al., «Menopause Transition and Cardiovascular Disease Risk», American Heart Association, 2020 (resumen ACC, dic. 2020).

HERRAMIENTA · 3 PASOS PARA ESTA SEMANA

01 **Fuerza 2 días.** Grandes grupos musculares, 2+ días por semana (OMS).

02 **150 minutos** de actividad moderada a la semana (OMS). Caminar rápido cuenta.

03 **Mide la cintura**, no solo el peso, y anótalo en tu diario o en la app.

Fuente: OMS, recomendaciones de actividad física para adultos. Plan completo en el cap. 07.

CAPÍTULO 03

Lo que no se ve *en silencio*



IDEA CLAVE *Los calores se notan; huesos, corazón y cerebro cambian en silencio. Este capítulo es de prevención, no de miedo.*

HUESOS · EL CAMBIO MÁS SILENCIOSO

El estrógeno ayuda a mantener el hueso. Cuando baja, la pérdida se acelera. La osteoporosis no duele hasta que llega una fractura: por eso conviene actuar antes.

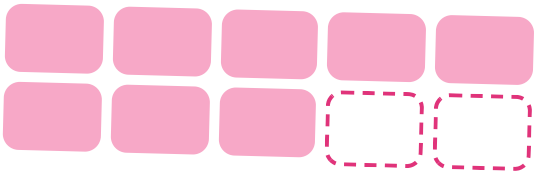
Si tu menopausia fue temprana o prematura (pág. 09), el riesgo es mayor: pide desde ya un plan para tus huesos.

Lo que más ayuda está a tu alcance: **fuerza 2+ días por semana** (OMS), suficiente calcio en la dieta y no fumar.

FIG. 18 · HASTA 1 DE CADA 5

20%

de densidad ósea puede perderse en los 5 a 7 años tras la menopausia.



Es un máximo («hasta»), no lo que le pasa a todas. Cada bloque = 10%. National Osteoporosis Foundation, citada por Vanderbilt Health, 2016 (rev. 2021).

CALCIO: CUÁNTO SE RECOMIENDA

1.200 mg

al día para mujeres de 51 a 70 años, idealmente de la comida: lácteos, yogur, sardinas con espina, algunas verduras de hoja. Antes de suplementos, consulta.

NIH, Oficina de Suplementos Dietéticos, «Datos sobre el calcio», rev. sep. 2023.

¿Me toca una densitometría?

Marca si te aplica (USPSTF, EE. UU., ene. 2025):

- ☐ Tengo 65 años o más.
- ☐ Soy posmenopáusica, menor de 65, con más riesgo: bajo peso, tabaco, mucho alcohol o madre/padre con fractura de cadera.

Los programas cambian según el país: pregunta cuál aplica en el tuyo. USPSTF, «Osteoporosis to Prevent Fractures: Screening», 14 ene. 2025.

prevenir **también es una forma de quererte. Huesos y corazón no avisan: tú sí puedes adelantarte.**

03 · CONTINUACIÓN

El corazón también entra en la transición

Durante años el infarto se pensó «cosa de hombres». Los datos dicen otra cosa, y esta etapa es una ventana para prevenir.

1 de 5
muertes de mujeres en EE. UU. en 2023 fue por enfermedad cardíaca: la primera causa.

56%
de las mujeres sabe que es su principal amenaza. Casi la mitad, no.

~80%
tiene calores en la mediana edad; se asocian a peores factores de riesgo cardiovascular.

Fuentes: CDC, «Women and Heart Disease», may. 2024; American Heart Association, declaración científica 2020 (resumen ACC).

FIG. 20 · QUÉ CAMBIA Y POR QUÉ

Más ligado a la menopausia	Más ligado a la edad
Colesterol LDL	Presión arterial
Apolipoproteína B	Insulina y glucosa

Además aumenta la grasa visceral y baja el músculo, ligado a más riesgo incluso con peso normal.
El Khoudary et al., American Heart Association, 2020 (resumen ACC).



cuidarlo también es esto

HERRAMIENTA · MIS NÚMEROS DEL CORAZÓN

	Valor	Fecha
Presión arterial		
Colesterol LDL		
Glucosa / HbA1c		
Cintura (cm)		
Min. actividad/sem.		

USPSTF: medir la presión a todas las adultas (2021); buscar prediabetes y diabetes de 35 a 70 años con sobrepeso u obesidad (2021).

La terapia hormonal iniciada antes de los 60 o en los 10 años tras la menopausia **parece** reducir el riesgo cardiovascular; falta investigación. Es una conversación con tu médica, no una indicación para todas (AHA, 2020).

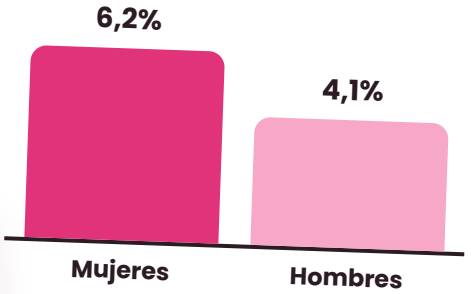
03 · CONTINUACIÓN

te veo

Pedir ayuda no es rendirse: es tomarte en serio.

La mayoría atraviesa la menopausia sin un problema de salud mental. Pero si el ánimo se apaga y no vuelve, no tienes que aguantarlo en silencio.

FIG. 22 · DEPRESIÓN, 2023



Adultos, mundo. Unas 1,5 veces más frecuente en mujeres. OMS, «Depresión», sep. 2026.

HERRAMIENTA · SEÑALES QUE MERECEN CONSULTA

Dos semanas o más, casi a diario, con ánimo bajo o sin interés por lo que disfrutabas, y además:

- [ ] dificultad para concentrarte;
- [ ] culpa excesiva o sensación de no valer;
- [ ] desesperanza sobre el futuro;
- [ ] cambios en el sueño o el apetito;
- [ ] cansancio marcado;
- [ ] pensamientos de muerte.

Basado en los síntomas de un episodio depresivo descritos por la OMS. No es un diagnóstico.



Qué hacer

01 Dilo en voz alta
A tu médica y a alguien de confianza. Lleva tu termómetro (pág. 14).

02 Que se evalúe aparte
La terapia hormonal alivia calores, no trata la depresión (*The Lancet*, 2024).

03 Terapia psicológica
La TCC puede mejorar ánimo y sueño (misma serie).

04 Cuida lo básico
Sueño, movimiento y compañía (caps. 07 y 09).

Si piensas en hacerte daño, busca ayuda hoy. Llama a la línea de emergencias o de crisis de tu país, ve a urgencias o pide a alguien de confianza que te acompañe.

HERRAMIENTA 03

mi salud

Tu mapa de chequeos

Llévalo a tu próxima consulta. Anota la fecha de tu último control y pregunta cuáles te tocan según tu edad, historia y país. No todos aplican a todas.

CHEQUEO	CUIDA	REFERENCIA (EE. UU., SALVO INDICACIÓN)	MI ÚLTIMA FECHA
Presión arterial	Corazón	A todas las adultas desde los 18. USPSTF, 2021.	
Colesterol	Corazón	LDL y ApoB suben con la menopausia: pregunta cuándo repetirlo. AHA, 2020.	
Glucosa	Metabolismo	De 35 a 70 años con sobrepeso u obesidad. USPSTF, 2021.	
Densitometría	Huesos	Desde los 65, o antes si eres posmenopáusica con más riesgo. USPSTF, 2025.	
Mamografía	Mama	Cada 2 años de los 40 a los 74. USPSTF, 2024.	
Citología / VPH	Cuello uterino	De 30 a 65: citología cada 3 años o VPH cada 5. USPSTF (Manual MSD).	
Colon	Colon	Detección de cáncer colorrectal de 45 a 75. USPSTF (Manual MSD).	
Ánimo	Mente	Consulta si llevas 2 semanas o más con ánimo bajo casi a diario. OMS.	
Sangrado	Útero	Cualquier sangrado tras 12 meses sin regla: consulta siempre. HSE (Irlanda).	

Fuentes: USPSTF (hipertensión, 2021; diabetes, 2021; osteoporosis, ene. 2025; mama, abr. 2024); Manual MSD, tabla de cribado según USPSTF; American Heart Association, 2020; OMS, «Depresión»; HSE, «Postmenopausal bleeding». Los programas varían según el país.

CIERRE DE LA PARTE I

Ya sabes qué cambia y qué vigilar. En la Parte II lo convertimos en un plan.

TRUCO

Haz una foto de esta página y guárdala en una carpeta «Mi salud», o anota las fechas en la app, en **Plantillas →**



PARTE II

Actuar

II

Entender fue el primer paso. Ahora: lo que sientes se vuelve datos, los datos se vuelven preguntas, y las preguntas, un plan tuyo.



EN ESTA PARTE

04 Tu diario de síntomas

05 La consulta que mereces

06 Tratamientos con evidencia

07 Cuerpo en movimiento

69%

de las pacientes que vio un video de 4 minutos con tres preguntas hizo al menos una en la consulta. Llegar preparada cambia la conversación.

Shepherd et al., Health Expectations, 2016 (121 pacientes, Sídney; sin grupo control).

04 diario

Tu diario de síntomas



2 minutos al día

LA IDEA CLAVE

Lo que se anota, se puede mostrar. Cuatro semanas de registro convierten «me siento mal» en datos que tu equipo de salud puede usar.

Los síntomas cambian de un día a otro. En una consulta corta cuesta recordar cuántas noches te despertaste o cuándo fue tu última regla. El diario lo resuelve.

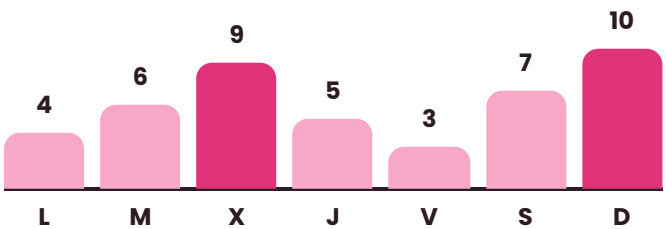
La guía británica NICE indica que, en mujeres sanas **mayores de 45 años**, la perimenopausia y la menopausia se diagnostican por los síntomas y el patrón de reglas, sin análisis. Tu registro es la prueba principal. Anota también medicamentos y suplementos (The Menopause Charity).

Fuentes: NICE, guía NG23 «Menopause: diagnosis and management»; The Menopause Charity, «How to ask your GP for help».

CÓMO USARLO · 5 PASOS

1. **Una hora fija.** Por la noche, antes de dormir.
2. **Cuenta los sofocos** del día y marca si hubo sudores nocturnos.
3. **Sueño:** horas y calidad de 0 a 3.
4. **Ánimo** de 0 (bien) a 3 (muy afectado).
5. **Sangrado y nota:** nada, manchado o regla.

FIG. 31 · SOFOCOS POR DÍA (EJEMPLO FICTICIO)



Los dos picos coinciden con noches de poco sueño: justo el patrón que conviene llevar a la consulta.

TU HERRAMIENTA DE HOY

El diario de 4 semanas está en las dos páginas siguientes. Imprímelo, rellénalo en PDF o anótalo en el celular:

menopausia-equilibrada.vercel.app/#hoy

IMPRIMIBLE Y RELLENABLE

Diario · semanas 1 y 2



1 y 2

Sofocos: n.º del día · **Sudor:** marca si te despertó · **Calidad y ánimo:** 0 nada · 1 leve · 2 medio · 3 fuerte · **Sangrado:** N nada · M manchado · R regla

Semana 1

del _____ al _____

DÍA	FECHA	SOFOCOS	SUDOR	SUEÑO (H)	CALIDAD	ÁNIMO	SANGRADO	NOTA
1			☐					
2			☐					
3			☐					
4			☐					
5			☐					
6			☐					
7			☐					

Total sofocos _____ **Noches con sudor** _____ /7 **Sueño medio** _____ h

Semana 2

del _____ al _____

DÍA	FECHA	SOFOCOS	SUDOR	SUEÑO (H)	CALIDAD	ÁNIMO	SANGRADO	NOTA
8			☐					
9			☐					
10			☐					
11			☐					
12			☐					
13			☐					
14			☐					

Total sofocos _____ **Noches con sudor** _____ /7 **Sueño medio** _____ h

OTROS SÍNTOMAS ESTAS 2 SEMANAS

- ☐ Sequedad o dolor íntimo
- ☐ Escapes de orina
- ☐ Ansiedad
- ☐ Irritabilidad

LO QUE MÁS ME AFECTÓ

IMPRIMIBLE Y RELLENABLE

Diario · semanas 3 y 4



3 y 4

Sofocos: n.º del día · **Sudor:** marca si te despertó · **Calidad y ánimo:** 0 nada · 1 leve · 2 medio · 3 fuerte · **Sangrado:** N nada · M manchado · R regla

Semana 3

del _____ al _____

DÍA	FECHA	SOFOCOS	SUDOR	SUEÑO (H)	CALIDAD	ÁNIMO	SANGRADO	NOTA
15			☐					
16			☐					
17			☐					
18			☐					
19			☐					
20			☐					
21			☐					

Total sofocos _____ Noches con sudor _____ /7 Sueño medio _____ h

Semana 4

del _____ al _____

DÍA	FECHA	SOFOCOS	SUDOR	SUEÑO (H)	CALIDAD	ÁNIMO	SANGRADO	NOTA
22			☐					
23			☐					
24			☐					
25			☐					
26			☐					
27			☐					
28			☐					

Total sofocos _____ Noches con sudor _____ /7 Sueño medio _____ h

MEDICAMENTOS Y SUPLEMENTOS QUE TOMO

FECHA DE MI ÚLTIMA REGLA

_____

MI PREGUNTA N.º 1 PARA LA CONSULTA

_____

Cómo leer tu diario

28 días

Cuatro lecturas sencillas convierten 28 días de datos en un resumen de una página.

01

Suma y promedia

Sofocos por día = total de las 4 semanas ÷ 28. Haz lo mismo con las horas de sueño y cuenta las noches con sudor por semana.

02

Busca relaciones

¿Las noches con sudor coinciden con peor ánimo al día siguiente? ¿Algo se repite antes de los días más difíciles?

03

Elige tus 3 prioridades

No siempre es lo más frecuente: es lo que más te limita. Tres sofocos al día pueden pesar menos que dormir cuatro horas.

04

Separa lo que no espera

Sangrado después de 12 meses sin regla: consulta sin esperar a la cita. Ánimo muy bajo o ideas de hacerte daño: busca ayuda hoy (cap. 08).

Lectura 01: cálculo propio, no un dato externo. Lectura 04: HSE (servicio de salud de Irlanda), «Postmenopausal bleeding».

HERRAMIENTA 04B · FIG. 32

Mi resumen para la consulta

Llévalo impreso o en una foto en el celular.

EDAD _____ **FECHA ÚLTIMA REGLA** _____

CICLOS ☐ regulares ☐ irregulares ☐ 60+ días sin regla ☐ 12+ meses sin regla

SOFOCOS / DÍA	SUDOR / SEMANA	SUEÑO MEDIO (H)	ÁNIMO MEDIO 0–3

MIS 3 PRIORIDADES

1 _____

2 _____

3 _____

MEDICAMENTOS _____

FAMILIA ☐ cáncer de mama ☐ infarto o ictus ☐ osteoporosis ☐ trombosis

HOY QUIERO SALIR SABIENDO _____

Campos basados en NICE (NG23) y The Menopause Charity. La app lo arma sola: menopausia-equilibrada.vercel.app/#consulta

05 consulta

La consulta que mereces



dos expertas en la mesa

20%
esperó 12+ meses a una evaluación

20%: Bonafide, *State of Menopause Survey*, en SWHR, feb. 2025 (EE. UU.).

LA IDEA CLAVE

Una buena consulta no depende de la suerte: se prepara. Llegar con datos y prioridades te convierte en coprotagonista de la decisión.

La OMS reconoce que el personal de salud a menudo no recibe formación suficiente sobre menopausia, y que el tema rara vez se habla en las consultas.

No es culpa tuya ni de una persona en concreto: es un vacío del sistema. Por eso prepararte no es desconfiar, es ayudar a que la consulta funcione.

Si tienes más de 45 años y estás sana, la guía NICE indica que el diagnóstico se basa en tus síntomas y tus reglas. No necesitas convencer a nadie con un análisis: necesitas un buen relato. Y ese relato ya está en tu diario.

Fuentes: OMS, nota descriptiva «Menopausia», 16 oct. 2024; NICE, guía NG23.

Deberías salir sabiendo...

- [ ] En qué etapa estás y cómo se diagnostica.
- [ ] Qué síntomas son esperables y cuáles no.
- [ ] Qué cambios de hábitos ayudan a tu salud.
- [ ] Tus opciones, con beneficios y riesgos.
- [ ] Qué implica para tu salud a largo plazo.

Fuente: NICE, guía NG23 (información que debe darse a cada mujer).

PARA IMPRIMIR Y LLEVAR

El guion de tu consulta

Cinco momentos, en orden. Marca antes las preguntas que más te importan y tacha las que te respondan.



01 PARA ABRIR

30 SEGUNDOS

«Vengo por síntomas que creo que tienen que ver con la perimenopausia. Traigo un registro de cuatro semanas. Lo que más me afecta es _____, _____ y _____. Hoy me gustaría salir con _____.»

02 PARA ENTENDER

- [ ] ¿En qué etapa estoy, según mis síntomas y mis ciclos?
- [ ] ¿Necesito algún análisis, o en mi caso se diagnostica por síntomas?
- [ ] ¿Hay otras causas que convenga descartar?

03 PARA DECIDIR

- [ ] ¿Cuáles son mis opciones?
- [ ] ¿Pros y contras de cada opción, para mí?
- [ ] ¿Dónde consigo información y apoyo para decidir?
- [ ] ¿Qué pasa si, por ahora, no hago nada?

04 PARA EL LARGO PLAZO

- [ ] ¿Me conviene revisar presión, colesterol o glucosa?
- [ ] ¿Debo evaluar mi salud ósea?
- [ ] ¿Mis antecedentes familiares cambian algo?

05 PARA CERRAR

- [ ] ¿Cuál es el plan y cuándo lo revisamos?
- [ ] ¿Qué señales deberían hacerme volver antes?
- [ ] Si hace falta, ¿a quién me puedes derivar?

Preguntar no es desconfiar. Es la forma en que una decisión llega a ser tuya.

Las tres primeras preguntas del bloque 03 son las de la campaña «Ask 3 Questions» del NHS para decidir de forma compartida; la cuarta es un añadido editorial. Opciones de tratamiento: capítulo 06.

Fuentes: NHS North Bristol Trust, «Ask 3 Questions»; NICE, guía NG23 (diagnóstico e información a la paciente). Guion: elaboración editorial. ¿Lo prefieres en el celular? Elige tus preguntas en menopausia-equilibrada.vercel.app/#consulta

Antes, durante y después

paso a paso

Antes

Si tu centro lo permite, pide una **cita más larga**.

Lleva diario, resumen y **lista de medicamentos y suplementos**.

Escribe tus **3 prioridades**.

Si te da seguridad, ve acompañada.

Durante

Di tus prioridades **al empezar**, no al final.

Toma notas, o pregunta si puedes grabar.

Repite con tus palabras lo que entendiste.

Usa las preguntas del bloque 03 del guion.

Después

Escribe el **plan acordado y la fecha** de revisión.

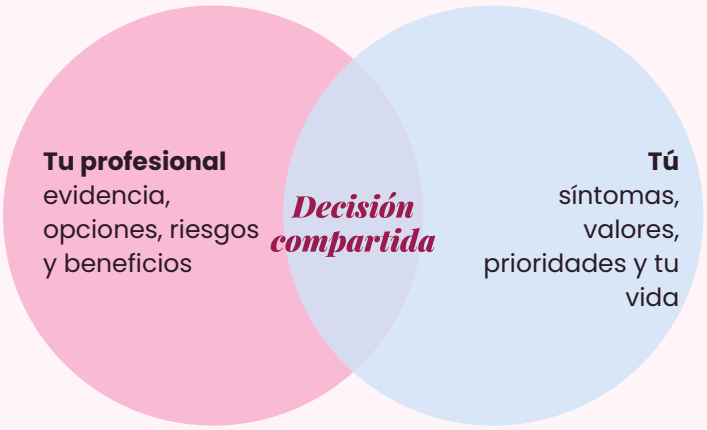
Sigue con el diario para medir si algo cambia.

Efectos secundarios o sin mejora: **pide revisión antes**.

Guarda informes y resultados en una carpeta.

Fig. 34 — Cita larga, prioridades al inicio, lista de medicamentos y revisión anticipada: The Menopause Charity, «How to ask your GP for help». El resto: recomendaciones editoriales.

FIG. 35 · LA DECISIÓN COMPARTIDA



87% hizo al menos una de las tres preguntas

43% hizo las tres

Entre 63 pacientes que, antes de una decisión de salud, vieron un video breve con tres preguntas. **Prepararse funciona, aunque sea poco.**

Shepherd et al., *Health Expectations*, 2016. Piloto sin grupo control, Sídney; datos autoinformados.

FRASE ÚTIL

«Para asegurarme de que entendí: lo que me propones es _____, y lo revisamos el _____. ¿Es así?»



insiste

Si no te escuchan

Que no te escuchen no significa que no tengas razón. Insistir con respeto y con datos también es cuidarte.



no estás sola

SEÑALES DE UNA CONSULTA QUE NO FUNCIONÓ

- ☐ Te dijeron «es la edad» y no te ofrecieron **ninguna opción**.
- ☐ No te explicaron beneficios y riesgos, ni qué pasa si no haces nada.
- ☐ Saliste sin plan ni fecha de revisión.
- ☐ No sabes qué hacer si empeoras.

FIG. 37 · LA ESCALERA RESPETUOSA

1. **Repite tu prioridad con tus datos**
2. **Pide otra cita, con más tiempo**
3. **Pide otro profesional del centro**
4. **Pide derivación a especialista**
5. **Busca una segunda opinión**

Basado en The Menopause Charity, «How to ask your GP for help».

GUION · PASO 1

«Entiendo que es frecuente. Aun así, según mi registro, me despierto _____ noches por semana y está afectando a _____. Me gustaría conocer mis opciones, o que me derives a alguien con experiencia en menopausia.»

A quién pedir derivación

Depende de tu caso: **ginecología**; **endocrinología** o medicina interna; **salud mental** si el ánimo no mejora; **fisioterapia de suelo pélvico** si hay escapes o dolor. Fuera del Reino Unido, The Menopause Charity sugiere consultar la International Menopause Society. (Orientación general, no un protocolo.)

06 opciones
Tratamientos con evidencia



LA IDEA CLAVE

No hay un tratamiento «mejor»: hay el que encaja con tus síntomas, tu salud y tus prioridades.

Hay **cuatro caminos** con respaldo científico y no compiten entre sí: muchas mujeres combinan dos. La terapia hormonal es la más estudiada para los sofocos, pero no la única.

Aquí no hay dosis, a propósito: este capítulo te da el mapa para decidir con tu profesional.

2–5 años
duración habitual de la terapia hormonal, a veces más, según el NHS. Ni «para siempre» por defecto, ni con fecha fija.
NHS, «Types of HRT».

FIG. 51 · EL MAPA DE OPCIONES

Terapia hormonal sistémica
Sofocos y sudores nocturnos; también protege el hueso.
PÁGS. 30–31

Tratamiento vaginal local
Sequedad, ardor, dolor en las relaciones. Cualquier edad.
PÁG. 32

Fármacos no hormonales
Sofocos, si no puedes o no quieres usar hormonas.
PÁG. 33

Terapias psicológicas
Sofocos, sueño y estrés: TCC e hipnosis clínica.
PÁG. 33

La base de todo: fuerza, movimiento, comida y sueño (cap. 07) no eliminan los sofocos según la evidencia, pero cuidan hueso, corazón y ánimo durante décadas.

Fuentes: The Menopause Society, declaraciones de posición sobre terapia hormonal (2022) y no hormonal (2023); NHS; serie The Lancet sobre menopausia (2024).

THM

Reponer lo que baja, con criterio



La terapia hormonal de la menopausia aporta estrógeno para compensar el que el ovario deja de producir. Es el tratamiento más estudiado para los sofocos y los sudores nocturnos.

SI YA NO TIENES ÚTERO

Solo estrógeno

Indicado si te extirparon el útero (histerectomía).

SI TIENES ÚTERO

Estrógeno + progestágeno

El estrógeno solo puede engrosar el revestimiento del útero; el progestágeno lo protege.

FIG. 52 · CÓMO LLEGA LA HORMONA

Pastillas	Diarias. Riesgo de coágulos algo mayor que por la piel, aunque pequeño.
Parches	Cada pocos días. Sin el riesgo extra de coágulos de las pastillas.
Gel o spray	Estrógeno en la piel a diario. Con útero, se suma un progestágeno.
DIU hormonal	Aporta el progestágeno dentro del útero; también es anticonceptivo.
Vaginal	Dosis baja y local para la zona íntima (pág. 32). No trata los sofocos.

Fuente: NHS, «Types of hormone replacement therapy (HRT)». Tu profesional elige vía y pauta.

> *Los beneficios superan los riesgos para la mayoría de las mujeres sanas con síntomas, menores de 60 años o en los 10 años siguientes a la menopausia.*
>
> The Menopause Society, posición sobre terapia hormonal, 2022 (traducción editorial).

FIG. 53 · LA VENTANA DE INICIO

< 60 años o < 10 años desde la menopausia	Después: más cautela

Esquema editorial, no a escala. Fuente: The Menopause Society, 2022.

¿Aún tienes reglas?

Suele usarse una **pauta secuencial**: el progestágeno se añade una parte del mes y aparece un sangrado esperado.

¿Un año sin regla?

Suele pasarse a **pauta continua**: ambas hormonas cada día. Un sangrado inesperado se consulta siempre.

Revisión periódica

Se revisa el balance cada cierto tiempo. Ojo con las hormonas «bioidénticas» de farmacia: menos reguladas.

Fuentes: NHS, «Types of HRT»; The Menopause Society, *Menopause*, 2022;29(7). Nada en esta página sustituye la indicación médica.

NI MIEDO NI MARKETING

Un riesgo relativo no es un riesgo absoluto

Y no todas las terapias hormonales son iguales.

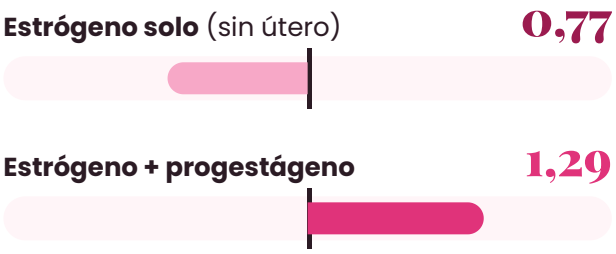


Gran parte del miedo a las hormonas nace del estudio **Women's Health Initiative (WHI)**, con más de 27.000 mujeres. Su seguimiento a largo plazo mostró algo que rara vez se cuenta completo: el resultado depende del tipo de terapia.

La serie de *The Lancet* (2024) advierte del otro extremo: el marketing de farmacéuticas y clínicas privadas a menudo minimiza riesgos pequeños pero serios. Y recuerda que la terapia hormonal alivia sofocos y sudores, pero **no trata la depresión**.

La vía también importa: según el NHS, las pastillas tienen un riesgo de coágulos algo mayor que parches, gel o spray, aunque pequeño.

FIG. 54 · CÁNCER DE MAMA EN EL WHI FRENTE A PLACEBO



0,77 = un 23% menos de casos que con placebo, en proporción. **1,29** = un 29% más, en proporción. No significa que 29 de cada 100 mujeres tendrán cáncer.

Chlebowski et al., *JAMA*, 2020, resumido en *The ASCO Post*, 25 ene. 2020. Ensayos del WHI con 10.739 y 16.608 mujeres.

Habla con tu médica antes de empezar si...

- ☐ Tuviste cáncer de mama o tienes alto riesgo familiar
- ☐ Tuviste un coágulo en pierna o pulmón
- ☐ Tuviste angina o infarto
- ☐ Tienes sangrado vaginal sin causa conocida
- ☐ Problemas de hígado, corazón o riñón
- ☐ Presión alta o colesterol muy alto
- ☐ Migrañas o dolores de cabeza fuertes
- ☐ Podrías estar embarazada o das lactancia

Selección de la lista del HSE (Irlanda), «Who can and cannot take continuous combined HRT». La lista completa es más larga.

«¿Cuál es mi riesgo, con mi historia, con esta vía y este tipo de terapia?»

Llévala escrita. Una buena consulta no termina en «sí» o «no», sino en un plan con fecha de revisión.

intimidad

La zona íntima tiene solución, a cualquier edad

Sequedad, ardor, dolor en las relaciones: el síndrome genitourinario (pág. 12) responde bien al tratamiento. No hace falta resignarse.



Los **estrógenos vaginales en dosis baja** (crema, gel, óvulo, tableta o anillo) actúan sobre la zona y, según The Menopause Society, pueden usarse a cualquier edad y por tiempo prolongado si hace falta.

Según el NHS, no requieren progestágeno aunque tengas útero, pero tampoco alivian los sofocos, el ánimo ni el sueño.

1 de 2

mujeres con síntomas genitourinarios, en una encuesta a 1.858, nunca había usado tratamiento.

The Menopause Society, declaración sobre SGM, 2020.

FIG. 56 · NO SON LO MISMO

	Hidratante vaginal	Lubricante	Estrógeno vaginal
PARA QUÉ	Sequedad de todos los días	Durante las relaciones sexuales	Causa hormonal de la sequedad y el dolor
CÓMO	Dentro de la vagina, para mantenerla hidratada	De base acuosa, en la zona, en pareja o juguetes	Con receta; forma y pauta según tu profesional
RECETA	**No**	**No**	**Sí**

Fuentes: NHS, «Vaginal dryness» y «Types of HRT»; The Menopause Society, posición sobre terapia hormonal, 2022.

EVITA

Jabones perfumados, duchas vaginales y cremas no vaginales: pueden irritar o causar infección.

SI TUVISTE CÁNCER DE MAMA

No lo empieces sin tu oncólogo: en casos seleccionados se valora en dosis baja.

CONSULTA PRONTO SI

La sequedad dura semanas, notas un flujo raro o hay sangrado tras las relaciones o tras la menopausia.

Fuentes: NHS, «Vaginal dryness»; The Menopause Society, 2022 (sobrevivientes de cáncer de mama con síntomas que no mejoran con tratamientos no hormonales).

SEMÁFORO DE EVIDENCIA

Opciones sin hormonas

En 2023, The Menopause Society revisó la evidencia de las opciones sin hormonas para los sofocos y los sudores nocturnos. Así separó lo que funciona de lo que solo se vende bien.

RECOMENDADO PARA SOFOCOS

- Terapia cognitivo-conductual (TCC)
- Hipnosis clínica
- Pérdida de peso, en algunas mujeres
- Algunos antidepresivos (ISRS e IRSN), en dosis que define tu médica
- Gabapentina
- Oxibutinina
- Fezolinetant (ver recuadro)
- Bloqueo del ganglio estrellado (procedimiento)

NO RECOMENDADO PARA SOFOCOS

- Suplementos y hierbas
- Productos de soja
- Cannabis
- Acupuntura y quiropraxia
- Respiración pausada
- Yoga, ejercicio y cambios de dieta
- Técnicas de enfriamiento y evitar desencadenantes
- Clonidina y pregabalina

Figs. 58–59. Fuente: The Menopause Society, posición sobre terapia no hormonal, *Menopause*, jun. 2023 (resumen de Breastcancer.org, 28 jun. 2023). «No recomendado» = evidencia insuficiente o desfavorable para los sofocos.

RECUADRO · FEZOLINETANT

Aprobado por la FDA de EE. UU. el **12 de mayo de 2023** para sofocos moderados o intensos. No es una hormona: bloquea el receptor NK3 en el hipotálamo, el centro que regula la temperatura.

Su ficha advierte de **aumento de enzimas hepáticas**: tu médica decidirá si necesitas análisis de control. Su disponibilidad varía según el país.

Revisión en PubMed Central (PMC12401328).

«No recomendado para los sofocos» no significa «inútil».



El ejercicio no apaga los sofocos, pero protege hueso, músculo y corazón (cap. 07). Y la serie de *The Lancet* (2024) señala que la TCC puede además reducir el estrés y mejorar el sueño y el ánimo.

Antes de cualquier fármaco

Cuéntale a tu médica todo lo que tomas, incluidos suplementos y hierbas, y pregunta cuánto tiempo probar antes de evaluar si funciona.

TU MESA DE DECISIÓN · RELLENABLE

Decide con datos, no con miedo

Rellénala antes de la consulta y termínala con tu profesional. La decisión es tuya; el criterio clínico, compartido. Y se revisa.



PASO 1 NUMERA TUS PRIORIDADES DEL 1 (LA MÁS IMPORTANTE) AL 6

- ☐ Dormir mejor
- ☐ Reducir los sofocos
- ☐ Aliviar la zona íntima
- ☐ Sentirme mejor de ánimo
- ☐ Proteger huesos y corazón
- ☐ Evitar medicamentos si puedo

PASO 2 FIG. 60 · COMPARA LAS OPCIONES QUE TU PROFESIONAL CONSIDERE

OPCIÓN	QUÉ ESPERO QUE MEJORE	RIESGOS PARA MÍ	QUÉ ME PREOCUPA	REVISIÓN (FECHA)
Terapia hormonal sistémica				
Estrógeno vaginal				
Fármaco no hormonal				
TCC o hipnosis clínica				
Esperar y observar				

PASO 3 CUATRO PREGUNTAS POR OPCIÓN

1. ¿Qué beneficio puedo esperar, y en cuánto tiempo?

2. ¿Qué riesgos tiene para mí, con mi historia?

3. ¿Qué alternativas tengo?

4. ¿Qué pasa si no hago nada por ahora?

PASO 4 LO QUE ACORDAMOS

Próxima revisión _____

Qué voy a observar _____

Si empeora, llamo a _____

Lo que hoy encaja puede cambiar en un año. Guarda esta hoja y vuelve a rellenarla en cada revisión. También puedes editarla y guardarla en la app: menopausia-equilibrada.vercel.app/#plantillas

Herramienta editorial de PAUSA, basada en el principio de decisión individualizada y reevaluación periódica de The Menopause Society (2022). No sustituye la valoración médica.

07 muévete

Cuerpo en movimiento



LA IDEA CLAVE

Moverte no apaga los sofocos, pero protege lo que no se ve: hueso, músculo, corazón y ánimo.

Tras la menopausia aumenta la grasa visceral y disminuye la masa muscular, según la American Heart Association. El movimiento es la herramienta más barata que tienes para frenar ambos cambios y cuidar el corazón.

150–300
min/semana de actividad moderada (OMS)

2+
días/semana de fuerza muscular (OMS)

7%
en perimenopausia cumple las recomendaciones (AHA)

<20%
come de forma saludable en esa etapa (AHA)

Fuentes: OMS, actividad física; AHA, declaración científica 2020 (resumen del ACC).

FIG. 62 · TU SEMANA MÍNIMA, HECHA CUENTA

L	M	X	J	V	S	D
30	F	30	30	F	30	30

5 días × 30 min de caminata vivaz = **150 min**, más 2 días de fuerza (F). Es un ejemplo: reparte como te funcione.

PÁG. 36
Fuerza en casa
Seis ejercicios, sin gimnasio.

PÁG. 37
Comida para el hueso
Calcio, vitamina D y el plato.

PÁGS. 38–39
Sueño y semana
Plan de noche y calendario.

Antes de empezar. Con osteoporosis o una enfermedad crónica, consulta antes de un programa nuevo (NHS).

fuerza

Seis movimientos para tus huesos

El ejercicio de resistencia hace que el músculo «tire» del hueso y lo estimule, explica el NHS. Hazlo **2 o más días por semana** (OMS), con descanso entre sesiones. Calienta 5 minutos caminando en el sitio.



UNA SILLA, UNA PARED, UNA MOCHILA

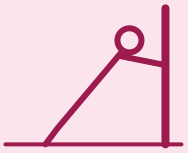
01



Sentarse y levantarse

Pies al ancho de caderas, sin impulso de brazos. Baja despacio hasta rozar la silla.

02



Flexiones contra la pared

Manos a la altura del pecho, cuerpo en bloque. Más lejos de la pared = más difícil.

03



Puente de glúteos

Boca arriba, rodillas dobladas. Eleva la cadera apretando glúteos y baja sin prisa.

04



Remo con mochila o banda

Inclínate con espalda recta, apoya una mano y lleva el peso hacia la cadera.

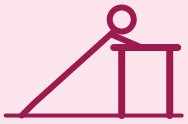
05



Elevación de talones

De pie, apoyada en una silla. Sube a puntillas y baja en tres tiempos.

06



Plancha inclinada

Antebrazos sobre una mesa firme, cuerpo recto, respira. Empieza con pocos segundos.

Cómo dosificar

Repite cada movimiento hasta que las últimas repeticiones cuesten sin perder la técnica. Haz el circuito 2 o 3 veces. Cuando sea fácil, añade peso o hazlo más lento. *Orientación editorial, no una prescripción.*

Para y consulta si

Sientes dolor agudo, mareo, falta de aire inusual o dolor en el pecho. Con osteoporosis, habla antes con tu profesional (NHS).

Fig. 63. Fuentes: NHS, «Osteoporosis — Prevention» (ejercicio de resistencia y con carga); OMS, recomendaciones de actividad física (fuerza 2 o más días por semana). Ilustraciones esquemáticas.

nutre

Calcio, vitamina D y un plato que te sostenga

Tras la menopausia, el hueso pierde un aliado: el estrógeno. La comida no sustituye un tratamiento, pero es la base diaria. Dos nutrientes mandan: el **calcio**, que forma el hueso, y la **vitamina D**, que ayuda a absorberlo.

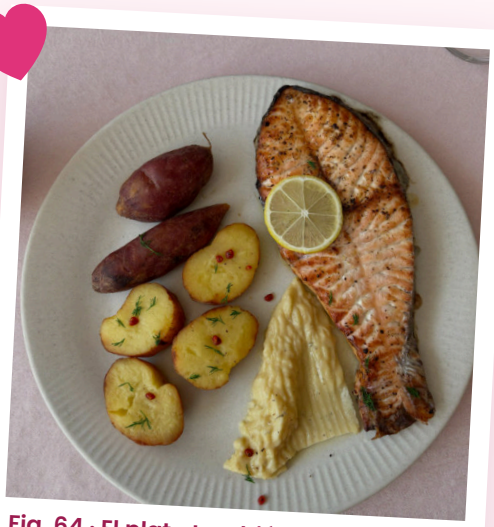


Fig. 64 · El plato también construye hueso

FIG. 65 · CALCIO AL DÍA: DEPENDE DE QUIÉN LO DIGA

NIH (EE. UU.)
mujeres 51–70 años — **1.200 mg**

NHS (Reino Unido)
adultos — **700 mg**

Las cifras cambian según el país y la guía. Pregunta cuál aplica para ti y **no tomes suplementos sin consultarlo**.

TRUCO NIH

≤500 mg

por toma: así el cuerpo absorbe mejor el calcio. Mejor repartirlo a lo largo del día.

Fuentes: NIH, Oficina de Suplementos Dietéticos (ODS), «Calcio» (rev. 19 sep. 2023); NHS, «Osteoporosis — Prevention».

DÓNDE ESTÁ EL CALCIO

Lácteos
Leche, yogur y queso.

Pescado en lata
Sardinas o salmón, con sus espinas.

Verduras
Col rizada, brócoli, bok choy.

Fortificados
Algunas bebidas de soya o almendra, tofus y cereales. Mira la etiqueta.

Vitamina D

600 UI
al día (15 mcg)
de 19 a 70 años

800 UI
al día (20 mcg)
desde los 71 años

Está en pescados grasos (trucha, salmón, atún, caballa), alimentos fortificados y, en menor medida, yema de huevo y queso.

Lo que también cuenta

Dejar de fumar reduce el riesgo de osteoporosis. El NHS aconseja **no superar 14 unidades de alcohol por semana** y evitar los atracones de bebida.

Fuentes: NIH, ODS, «Calcio» y «Vitamina D — Datos en español» (rev. 8 nov. 2022); NHS, «Osteoporosis — Prevention». Información general: con enfermedad renal o medicación, consulta antes de cambiar dieta o suplementos.

descansa

Entrenar la noche, empezando por la mañana

El insomnio es uno de los síntomas de la menopausia que reconoce la OMS. La terapia cognitivo-conductual (TCC) tiene evidencia para el sueño, el ánimo y también los calores (serie de *The Lancet*, 2024). Estos hábitos del NHS son el punto de partida.



tu ritual de noche

FIG. 66 · TU RITUAL, A LA MISMA HORA

FIG. 67 · LA CUENTA ATRÁS DE CADA NOCHE

-6 h	-4 h	Cena	-1 h	Cama
Sin café, té, alcohol ni tabaco.	Sin ejercicio. Muévete de día.	Evita las comidas grandes muy tarde.	Relájate. Pantallas fuera.	Solo con sueño. Cuarto oscuro y en silencio.

Fuente: NHS, «Insomnia». Hábitos generales de higiene del sueño; no sustituyen una evaluación.

La regla de oro

Levántate a la **misma hora todos los días**, también tras una mala noche. Sin siestas para «recuperar».

Si te despiertas con calor

Un cuarto fresco da comodidad, aunque enfriarse no reduce los calores. Anótalo y coméntalo (pág. 33).

Consulta si

Llevas meses durmiendo mal o te cuesta funcionar de día. Pregunta por la TCC para el insomnio.

Mini-registro · 7 noches

Llévalo a la consulta con tu diario (cap. 04)

	1	2	3	4	5	6	7
Me acosté a las							
Me levanté a las							
Despertares							
Sudores (sí/no)							

Fuentes: NHS, «Insomnia»; OMS, «Menopausia» (2024); serie *The Lancet* sobre menopausia (2024); The Menopause Society, terapia no hormonal (2023).

mi semana

Pequeño, repetido, marcado

Fotocopia esta página o úsala como modelo. Marca cada casilla al cumplirla. Las casillas **rosadas** proponen tus días de fuerza: muévelos a tu gusto.



Fig. 68 · Moverse acompañada también cuenta

FIG. 69 · CALENDARIO SEMANAL CON CASILLAS

HÁBITO	L	M	X	J	V	S	D
Fuerza 2+ días (OMS)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Movimiento 30 min meta: 150 a la semana	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Calcio repartido en varias tomas al día	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Misma hora al despertar también el fin de semana	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Diario de síntomas un minuto (cap. 04)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Sin pantallas 1 h antes de dormir	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Algo solo para mí aunque sean 10 minutos	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Basado en: OMS, actividad física (150–300 min y fuerza 2+ días); NIH, calcio en tomas de 500 mg o menos; NHS, «Insomnia». Herramienta editorial.

La entrega del domingo · 10 minutos

- ☐ Revisé el diario y marqué el síntoma que más me afectó.
- ☐ Sumé mis minutos de movimiento.
- ☐ Hice fuerza al menos 2 días.
- ☐ Anoté una pregunta para mi próxima consulta.
- ☐ Me reconocí un logro, por pequeño que sea.

MINUTOS ESTA SEMANA

_____ / 150

«Una semana incompleta no es un fracaso: es información para la próxima.»

Guárdala también en la app: **Plan 30 días →**

PARTE III

Compartir

Nadie atraviesa la menopausia sola, aunque a veces lo parezca. Esta parte es para ti y para quienes te rodean: empatía hacia adentro, responsabilidad compartida hacia afuera.

EN ESTA PARTE

08 La empatía empieza por ti

09 Responsabilidad compartida

10 Mitos y preguntas



hablarlo cambia todo

FIG. 70 · HABLARLO CAMBIA LO QUE SE PUEDE HACER

EL PESO DEL SILENCIO

3 de 4

mujeres que nunca trataron sus síntomas genitourinarios tampoco los habían comentado nunca con un profesional.

Cifra aproximada («casi tres cuartas partes»), encuesta a 1.858 mujeres. The Menopause Society, declaración sobre SGM, 2020.

08 empatía



CAPÍTULO 08

La empatía empieza *por ti*

LA IDEA CLAVE

No puedes elegir tus síntomas, pero sí cómo te hablas mientras los atraviesas. Esa voz interna también es parte del cuidado.

En esta etapa es fácil volverse dura con una misma: «estoy insoportable», «ya no sirvo», «debería poder con todo». Esa voz no ayuda, y agota.

La serie de *The Lancet* (2024) recuerda que la menopausia, por sí sola, no suele causar problemas de salud mental, pero el riesgo de depresión sube con calores intensos, antecedentes de depresión o estrés reciente. Cuidar tu ánimo no es un lujo: es prevención.

3×

menos interferencia de los calores en la vida diaria entre mujeres con alta autocompasión, con la misma frecuencia de calores.

Estudio transversal, 206 mujeres: muestra una asociación, no una causa. Brown, Bryant y Judd, Univ. de Melbourne, 2014.

Los 3 ingredientes de la autocompasión

FIG. 72

01

Darte cuenta

Nombra lo que pasa: «estoy teniendo un calor y me da vergüenza».

02

Tratarte con amabilidad

Háblate como a una amiga y respeta los límites de tu cuerpo.

03

No estás sola

Una cuarta parte de las mujeres del mundo tiene 50 años o más.

Modelo descrito por la Universidad de Melbourne (2017). «Una cuarta parte»: OMS, «Menopausia», 2024.

08 · CONTINUACIÓN

suave

Autocompasión en la práctica

No es conformismo ni lástima. Es un hábito que se entrena, como la fuerza: pequeñas repeticiones, todos los días. Estas dos prácticas toman menos de cinco minutos.

Práctica 1 · Reescribe tu diálogo interno

FIG. 73

LO QUE ME DIGO	LO QUE LE DIRÍA A UNA AMIGA	LO QUE VOY A HACER
«Estoy insoportable, nadie me aguanta.»	«Llevas semanas durmiendo mal. Cualquiera estaría irritable.»	Anotar el sueño en mi diario y llevarlo a consulta.
«Se me olvida todo, me estoy apagando.»	«Tienes mil cosas encima. Vamos por partes.»	Usar listas y pedir ayuda con una tarea esta semana.
«Qué vergüenza sudar así en la reunión.»	«Es un síntoma, no un defecto. Le pasa a muchas.»	Llevar ropa por capas y un vaso de agua.

AHORA TÚ

Basado en los componentes de la autocompasión (Universidad de Melbourne, 2017). Ejemplos escritos por el equipo editorial.

Práctica 2 · La pausa de 3 minutos

1. **Para.** Pon una mano en el pecho o en el abdomen. Nota dónde sientes la incomodidad.
2. **Nombra.** «Esto es difícil ahora mismo.» Sin juzgarlo, sin pelearte con ello.
3. **Elige** una frase amable y una acción pequeña: agua, aire fresco, un mensaje a alguien.

Ojo: respirar despacio calma, pero no está respaldado como tratamiento de los calores (The Menopause Society, 2023). ¿Quieres ir más allá? La terapia cognitivo-conductual tiene evidencia para calores, sueño y ánimo (cap. 06; serie «Menopause», *The Lancet*, 2024).



«No es falta de voluntad. Es biología, y merece paciencia.»

deseo

Deseo e *intimidad*

La OMS advierte que la salud sexual de las mujeres en la menopausia se pasa por alto con frecuencia. Hablar de ella no es frivolidad: es salud.



El deseo puede cambiar por muchas razones a la vez: dormir mal, el estrés, la relación, algunos medicamentos o el dolor. Y el dolor tiene una causa frecuente y tratable: el **síndrome genitourinario de la menopausia** (SGM): sequedad, ardor o molestias en las relaciones.

Sin tratamiento suele avanzar; con tratamiento mejora. Por eso conviene hablarlo, no esperar a que «se pase».

> *Si duele, no es «normal de la edad»: es una señal para consultar.*
>
> Tu cuerpo sigue siendo tuyo.

Opciones para la sequedad y el dolor, de menos a más

FIG. 76

Lubricante SIN RECETA	En el momento de la relación. Menos fricción y dolor. Alivia, pero no trata la causa.
Hidratante vaginal SIN RECETA	Uso regular (en general 2–3 veces por semana). Humedad del día a día, aunque no haya relaciones.
Con receta	Estrógeno vaginal en dosis baja, DHEA vaginal (prasterona) u ospemifeno oral. El estrógeno vaginal puede usarse a cualquier edad. Decide con tu médica.
Suelo pélvico	Fisioterapeuta especializada para dolor, tensión muscular o escapes de orina.

The Menopause Society: SGM (2020) y terapia hormonal (2022); OMS, «Menopausia», 2024. No sustituye la consulta.

PARA DECIRLO EN PAREJA

«Quiero que sigamos cerca. Últimamente me duele y por eso lo evito. No es por ti. ¿Vamos con calma?»

PARA DECIRLO EN CONSULTA

«Tengo sequedad y dolor desde hace [tiempo] y me afecta. ¿Qué opciones tengo, con y sin hormonas?»

RECORTA O FOTOGRAFÍA ESTA PÁGINA

Señales de alarma: cuándo no esperar



Casi todo en la menopausia se atiende con calma. Algunas cosas no. Cuidarte también es saber cuándo pedir ayuda ya. En la app: menopausia-equilibrada.vercel.app/#alarma

NIVEL 1

Urgente

Hoy mismo. Llama a emergencias o a una línea de crisis de tu país.

- Tienes pensamientos de hacerte daño o sientes que estás en peligro. No esperes a sentirte «peor»: pide ayuda ahora y no te quedes sola.
- Alguien cercano te dice que piensa en hacerse daño: acompáñale y busquen ayuda de emergencia juntas.

NIVEL 2

Pide cita pronto

En los próximos días. No esperes a la revisión anual.

- Cualquier sangrado tras 12 meses sin regla, aunque sea leve, una sola vez o solo un manchado.
- Más de 40 años y sangrado entre reglas o después de las relaciones.
- Tristeza, vacío o pérdida de interés casi todos los días durante 2 semanas o más.
- Tus reglas desaparecieron antes de los 40 años.

NIVEL 3

Coméntalo

En tu próxima consulta, con tu diario en la mano.

- Síntomas que alteran tu sueño, tu trabajo o tus relaciones.
- Sequedad vaginal, dolor en las relaciones o escapes de orina.
- Dudas sobre anticoncepción, tratamientos o tu riesgo de huesos y corazón.

Fig. 77 — Lista orientativa, no exhaustiva. HSE (Irlanda), «Postmenopausal bleeding»; nidirect, «Bleeding between periods», dic. 2024; OMS, «Depresión», sep. 2026; OMS, «Menopausia», oct. 2024.

Complétalo ahora, antes de necesitarlo

Emergencias de mi país: _____

Línea de crisis: _____

Mi médica o centro: _____

Persona de confianza: _____

Por qué el sangrado importa: casi siempre tiene causas benignas (tejido más fino, pólipos). Rara vez es cáncer, pero se trata mejor si se detecta pronto (HSE).

Pedir ayuda no es exagerar. La OMS recomienda hablar con alguien de confianza y con un profesional si tienes síntomas de depresión.

09 juntas



CAPÍTULO 09

Responsabilidad compartida

LA IDEA CLAVE

Cuidarte no es solo tarea tuya. La menopausia ocurre en una casa, en un equipo de trabajo y en un sistema de salud.

La OMS lo dice claro: la menopausia rara vez se habla en familias, trabajos o servicios de salud, y el personal sanitario a menudo no recibe formación suficiente.

En un estudio con 137 mujeres citado por *The Lancet* (2024), lo que pedían era sencillo: jefes informados y empáticos.

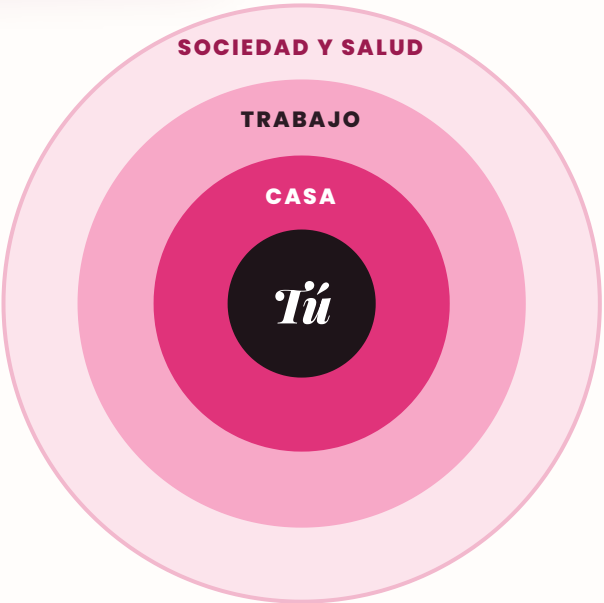


FIG. 78 · CÍRCULOS DE RESPONSABILIDAD

Qué le toca a cada círculo

- **Tú:** informarte, registrar y pedir sin culpa.
- **Casa:** escuchar, repartir la carga, proteger el descanso.
- **Trabajo:** líderes informados, ajustes y confidencialidad.
- **Sociedad y salud:** formación, información y políticas.

En este capítulo: guía para tu pareja **(pág. 46)**, palabras para tu familia **(47)** y cómo hablarlo en el trabajo **(48–50)**.

OMS, «Menopausia», 16 oct. 2024; serie «Menopause» de The Lancet (nota de King's College London, 6 mar. 2024).

para ti, que acompañas

Esta página está escrita para que ella te la pase. Si la estás leyendo, ya diste el primer paso: querer entender.



FIG. 79 · ACOMPAÑAR SE APRENDE

7,4 años
duran, en mediana, los calores frecuentes. No es «una etapa corta».

4,5 años
siguen, en mediana, después de la última regla. Y cambian con el tiempo.

Avis et al., estudio SWAN, JAMA Intern Med, 2015; NHS England, «Menopause for partners».

Lo que ayuda

Escucha sin arreglar
Pregunta «¿qué necesitas hoy?» antes de proponer.

Protege el sueño
Mantas distintas o dormir aparte alguna noche, sin dramas.

Reparte la carga
Asume tareas sin que te las pidan.

Infórmate
Lee la Parte I. Ofrece ir a la consulta, si ella quiere.

Lo que no ayuda

- ✕ «Son cosas de la edad.»
- ✕ «Estás exagerando.»
- ✕ «¿Otra vez con lo mismo?»
- ✕ Tomarte cada cambio de humor como algo personal.

GUION · UNA CONVERSACIÓN DE 10 MINUTOS

En un momento tranquilo, no en medio de una discusión

1. **Abre.** «Quiero entender mejor lo que estás viviendo. ¿Me cuentas?»
2. **Valida.** «Tiene sentido que estés agotada si no duermes bien.»
3. **Ofrece.** «¿Qué cosa concreta puedo hacer esta semana?»

en casa

Hablarlo sin pedir perdón

La OMS señala que la menopausia rara vez se habla en las familias. Romper ese silencio no te expone: les da a los tuyos la oportunidad de entenderte, y a tus hijas, de llegar mejor preparadas.



FIG. 81 · LAS AMIGAS TAMBIÉN CUIDAN

Qué decir, según con quién hablas

FIG. 82

HIJOS PEQUEÑOS

«Mi cuerpo está cambiando. A veces tengo calor o estoy cansada. No es culpa de nadie, y estoy bien cuidada.»

ADOLESCENTES

«Estoy en la menopausia: mis hormonas cambian y eso afecta mi sueño y mi ánimo. Si me ves irritable, no es contra ti.»

HIJOS ADULTOS Y AMIGAS

«Estoy pasando por esto y me vendría bien apoyo. ¿Puedo contarte cómo me siento y qué necesito?»

Frases orientativas escritas por el equipo editorial. Adáptalas a tu forma de hablar.

Con tu madre, tías o hermanas: pregúntales cómo vivieron su menopausia. Muchas nunca lo contaron porque nadie preguntó.

Con tus amigas: una charla honesta, un grupo de caminata o un chat compartido convierten el aislamiento en red.

HERRAMIENTA

Carta para compartir

Rellénala, fotografíala o léela en voz alta

Querida/o _____ :

Quiero contarte algo que estoy viviendo. Estoy en la menopausia y desde hace un tiempo noto

_____ .

Algunos días me siento _____ , y no es por ti.

Lo que más me ayudaría ahora es _____ .

Lo que no me ayuda es _____ .

Gracias por querer entenderme. Con cariño, _____

Consejo: si quien la recibe es tu pareja, entrégale también la página 46.

trabajo

La menopausia también va a trabajar



LA IDEA CLAVE

Los síntomas no se quedan en casa. Un trabajo informado no es un favor: es no perder talento.

Más del 75% de las mujeres sigue trabajando durante la transición y años después: la menopausia ocurre en plena vida laboral, a menudo en los años de más responsabilidad.

SWHR, Menopause Fact Sheet, feb. 2025 (datos de la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU.).

ENCUESTA MAYO CLINIC · 4.440 MUJERES EMPLEADAS DE 45 A 60 AÑOS

11%
faltó al menos un día al trabajo en el último año por sus síntomas.

13,4%
tuvo al menos una consecuencia laboral negativa.

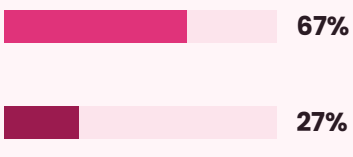
1.800
millones de dólares al año en tiempo de trabajo perdido (EE. UU.).

26.600
millones al año sumando gastos médicos (EE. UU.).

Faubion et al., Mayo Clinic Proceedings, 2023 (encuesta de 2021). Las cifras en dólares son estimaciones del estudio.

Mujeres con síntomas que trabajan

FIG. 91



CIPD, Menopause in the workplace, oct. 2023; más de 2.000 mujeres de 40 a 60 años (Reino Unido).

En el Reino Unido, las mujeres de 45 a 54 años reportan más estrés laboral que otros grupos (HSE).

En un estudio con 137 mujeres, lo que más pedían: **jefes informados y empáticos**. El guion, en la pág. 49.

Serie «Menopause», The Lancet (King's College London, mar. 2024).

Hablarlo en el trabajo no es exponerse: es dejar de cargar sola con algo que tiene solución.

EN EL TRABAJO

El guion para hablar con tu jefe

tu voz



No tienes que contar tu historia clínica. Basta con nombrar lo que pasa, explicar cómo afecta tu trabajo y proponer soluciones.

GUION EN 5 PASOS

Adáptalo a tus palabras

1. **Pide el espacio**
   «¿Tienes 20 minutos esta semana? Quiero hablarte de algo de salud que afecta mi trabajo.»
2. **Nómbralo**
   «Estoy en la perimenopausia. Es normal, pero algunos síntomas me complican el día a día.»
3. **Explica el impacto**
   «Duermo mal varias noches y en reuniones largas los calores me desconcentran.»
4. **Propón ajustes**
   «Me ayudaría un ventilador y poder empezar más tarde tras una mala noche.»
5. **Acuerda una revisión**
   «¿Lo probamos un mes y lo revisamos juntos?»

Antes de la reunión

- [ ] Anota 2 o 3 situaciones concretas (de tu diario).
- [ ] Elige qué quieres contar y qué no.
- [ ] Lleva 2 ajustes concretos.
- [ ] Revisa si tu empresa tiene política o guía.

Ajustes que puedes pedir

Opciones, no derechos garantizados: depende de tu país y tu empresa.

- [ ] Ventilador o puesto cerca de una ventana
- [ ] Agua fría a mano
- [ ] Acceso fácil al baño
- [ ] Uniforme de tela más fresca
- [ ] Horario flexible o remoto algunos días
- [ ] Pausas breves cuando aparece un calor
- [ ] Que las ausencias por síntomas no penalicen
- [ ] Reuniones de seguimiento periódicas

Basado en CIPD, Menopause in the workplace, oct. 2023.

Si te piden detalles: «Prefiero no entrar en detalles médicos; lo importante es cómo resolverlo.»

Déjalo por escrito: envía un correo breve con lo acordado y la fecha de revisión.

Si no hay respuesta: acude a RR. HH., a salud laboral o a tu representación sindical.

Las frases son ejemplos redactados por el equipo editorial. Las normas laborales varían por país: consulta la legislación local o a un asesor laboral.

Pedir ajustes no es pedir favores: es decir lo que necesitas para hacer bien tu trabajo.

ARRANCA ESTA PÁGINA Y DÉJALA EN RR. HH.

Seis acciones para una empresa que no pierde talento



Lo que una empresa hace, o deja de hacer, decide si una mujer pide ayuda o se va en silencio. Las seis acciones vienen de las recomendaciones del CIPD, el instituto británico de gestión de personas.

67% notó un efecto mayormente negativo en su trabajo.

27% siente un impacto negativo en su progreso profesional.

CIPD, Menopause in the workplace, 4 oct. 2023; más de 2.000 mujeres de 40 a 60 años, empleadas y con síntomas (Reino Unido).

Autodiagnóstico para la empresa

FIG. 92 · MARCA UNA CASILLA POR FILA

	ACCIÓN	LO TENEMOS	EN MARCHA	FALTA
01	**Cultura abierta** Se habla de la menopausia sin burla ni tabú.	☐	☐	☐
02	**Política o guía escrita** Qué apoyo existe, a quién acudir, cómo pedir ajustes.	☐	☐	☐
03	**Flexibilidad real** Horario o lugar de trabajo adaptados a cada puesto.	☐	☐	☐
04	**Ausencias justas** La política de ausencias no penaliza síntomas persistentes.	☐	☐	☐
05	**Mandos formados** Conocen los síntomas y saben tener una conversación sensible.	☐	☐	☐
06	**Ajustes de confort** Espacios frescos, agua fría, baños accesibles, uniformes adecuados.	☐	☐	☐

Cuidar a quien atraviesa la menopausia es una responsabilidad compartida entre la persona, su equipo y la organización.

EMPRESA QUE CUIDA

10 mitos



FIG. 93 · NO TE LO TRAGUES: PREGUNTA POR LA FUENTE

CAPÍTULO 10

Mitos y *preguntas*

LA IDEA CLAVE

Un mito repetido mil veces sigue siendo un mito. La evidencia cambió; la conversación también.

Muchas decisiones se toman con información de pasillo: lo que le pasó a una tía, un titular alarmante, un consejo de redes. Algunas ideas eran razonables hace veinte años; otras nunca tuvieron base.

Aquí pones diez mitos frente a la evidencia, con su fuente, y las preguntas que más se repiten. La meta no es decirte qué hacer: es que **decidas con datos**.

45%

no conocía la diferencia entre perimenopausia y menopausia antes de vivirla.

Bonafide, citada por SWHR, feb. 2025.

LOS 10 MITOS · PÁGS. 52–53

01	Es una enfermedad que hay que curar
02	Antes de los 45 es demasiado pronto
03	Hace falta un análisis para saberlo
04	Ya no puedo quedar embarazada
05	Los calores duran unos meses
06–10	Hormonas, suplementos, ánimo, sexo y peso

Cuestionar un mito no es desconfiar de tu familia ni de tu médica: es pedir que las decisiones sobre tu cuerpo se tomen con la mejor información.

SIN MIEDO · SIN MARKETING · CON FUENTES · PARA DECIDIR TÚ

Mito vs. realidad

verdad

Lo que se repite, frente a los datos. · FIG. 94



01 MITO

«La menopausia es una enfermedad que hay que curar.»

REALIDAD

Es una etapa natural del envejecimiento. *The Lancet* advierte contra tratarla solo como algo a medicar. Pero natural no es aguantar: los síntomas que afectan tu vida merecen atención.

OMS, «Menopausia», oct. 2024; serie «Menopause», The Lancet, mar. 2024.

02 MITO

«Con menos de 45 años es demasiado pronto.»

REALIDAD

Cerca del **10%** de las mujeres tiene menopausia prematura (antes de los 40) o temprana (40–44). Merece evaluación: se asocia a más riesgo cardiovascular y de osteoporosis.

Serie «Menopause», The Lancet, 2024 (nota de King's College London).

03 MITO

«Necesito un análisis de sangre para saberlo.»

REALIDAD

En mujeres sanas de más de 45 años con síntomas, NICE indica diagnosticar por los síntomas y el patrón de la regla, sin análisis. Antes de los 45 sí pueden considerarse pruebas.

NICE, guía NG23, 2015, act. 2019.

04 MITO

«Si mis reglas son irregulares, no puedo quedar embarazada.»

REALIDAD

En la perimenopausia todavía es posible. Mantén anticoncepción hasta 2 años tras la última regla entre los 40 y 50 años, y 1 año después de los 50.

EMAS, Menopause Essentials 2026: Contraception, jul. 2026.

05 MITO

«Los calores duran unos meses y se van solos.»

REALIDAD

En el estudio SWAN, la duración total mediana fue de **7,4 años**; en mujeres hispanas, **8,9**. Esperar no es un plan: hay tratamientos con evidencia (cap. 06).



Avis et al., JAMA Internal Medicine, 2015 (1.449 mujeres con síntomas frecuentes).

Cuestionar un mito no es desconfiar: es pedir que tus decisiones se tomen con la mejor información.

SIGUE EN LA PÁG. 53

PREGUNTAS: PÁG. 54

Mito vs. realidad

verdad

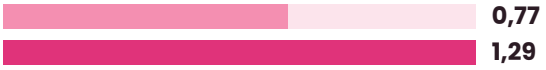
Las decisiones de tratamiento, siempre con tu médica. · FIG. 35

06 MITO

«La terapia hormonal siempre causa cáncer de mama.»

REALIDAD

Depende del tipo. En el ensayo WHI, el estrógeno solo (sin útero) se asoció a **menos** casos; estrógeno + progestágeno, a **más**. Para la mayoría de mujeres sanas con síntomas, menores de 60 o en los 10 años tras la menopausia, los beneficios superan los riesgos.



Razón de riesgo frente a placebo (1 = sin diferencia). Chlebowski et al., JAMA, 2020 (vía ASCO Post); The Menopause Society, 2022.

07 MITO

«Lo natural funciona igual: suplementos, hierbas y soja.»

REALIDAD

Para los calores, The Menopause Society no recomienda suplementos, hierbas, soja, yoga ni acupuntura. Sí: terapia cognitivo-conductual, hipnosis clínica y varios fármacos no hormonales. El ejercicio cuida huesos y corazón.

The Menopause Society, terapia no hormonal, jun. 2023.

08 MITO

«Las hormonas curan la depresión de la menopausia.»

REALIDAD

La terapia hormonal alivia calores y sudores, pero no trata la depresión. El riesgo en la perimenopausia es cerca de un **40% mayor**. Si la tristeza persiste, pide ayuda específica (cap. 08).

The Lancet, 2024; Badawy et al., J. Affective Disorders, 2024 (7 estudios, 9.141 mujeres).

09 MITO

«La sequedad vaginal es algo con lo que hay que vivir.»

REALIDAD

Afecta a entre el 27% y el 84% de las posmenopáusicas y tiene tratamiento, a cualquier edad. Tu vida sexual no tiene fecha de caducidad.

The Menopause Society: SGM (2020) y terapia hormonal (2022).

10 MITO

«Engordar es inevitable, o falta de voluntad.»

REALIDAD

Ni lo uno ni lo otro. La grasa se redistribuye hacia el abdomen y baja la masa muscular, incluso sin cambiar de peso. Cuidar el estilo de vida en la transición puede prevenir el aumento de peso.

El Khoudary et al., American Heart Association, 2020 (resumen ACC).

La evidencia cambió. Pregunta por la tuya: tu caso merece una conversación, no un titular.

¿MÁS DUDAS?

Las 8 preguntas de siempre, en la pág. 54.

RESPUESTAS CLARAS

Las preguntas de siempre

Ocho respuestas cortas para releer cuando aparezca la duda. Cada una remite a su capítulo.



P. ¿Cuánto dura todo esto?

Varía mucho. En el estudio SWAN, los calores duraron una mediana de 7,4 años en total y 4,5 tras la última regla. No todas los tienen igual. CAP. 02

Avis et al., JAMA Intern Med, 2015.

P. ¿Tengo que tomar hormonas sí o sí?

No. Hay opciones hormonales, no hormonales y psicológicas. La decisión es tuya, informada y acompañada, sin presiones. CAP. 06

Serie «Menopause», The Lancet, 2024.

P. ¿Hasta cuándo necesito anticoncepción?

Hasta 2 años tras la última regla si tienes entre 40 y 50 años; 1 año si tienes más de 50. CAP. 01

EMAS, Menopause Essentials 2026.

P. ¿Es normal sangrar tras la menopausia?

No es para esperar. Cualquier sangrado tras 12 meses sin regla se consulta. El cáncer es poco frecuente, pero hay que descartarlo. CAP. 08

HSE (Irlanda), «Postmenopausal bleeding».

P. ¿Necesito un análisis para confirmarlo?

Con más de 45 años y síntomas, en general no: se diagnostica por los síntomas y la regla. Antes de los 45, tu médica puede pedir pruebas. CAP. 01

NICE, guía NG23, act. 2019.

P. ¿El ejercicio me quitará los calores?

No hay evidencia suficiente. Pero protege corazón, huesos y ánimo: 150 minutos moderados a la semana y fuerza 2 días o más. CAP. 07

The Menopause Society, 2023; OMS, actividad física.

P. Tuve cáncer de mama. ¿Puedo tratar la sequedad?

Primero, opciones sin hormonas. Si no funcionan, datos observacionales sugieren que el estrógeno vaginal a dosis baja parece seguro en algunas sobrevivientes. Decídelo con oncología. CAP. 06

The Menopause Society, 2022.

P. ¿Y si mi médico me dice «es la edad»?

Lleva tu diario, pide que se registre lo que cuentas y, si no te escuchan, busca una segunda opinión. Mereces una consulta donde tus síntomas cuenten. CAPS. 04–05

Mi pregunta para la próxima consulta

FIG. 96

Guárdala también en la app: menopausia-equilibrada.vercel.app/#consulta · Esta página no sustituye una consulta médica.

Empieza *aquí.*



No tienes que leerlo todo ni cambiarlo todo. Solo da este primer paso esta noche, antes de dormir.

5 MINUTOS **SIN APPS, O CON APP**

3 SÍNTOMAS

7 DÍAS

1 CONVERSACIÓN

Elige los **3 síntomas** que más te afectan (mapa de la pág. 12). Durante **7 días**, puntúa cada uno de 0 a 3 antes de dormir. El octavo día, lleva esta hoja a **1 conversación**: con tu médica o con quien te acompaña.

¿PREFIERES EL CELULAR?
Haz el mismo registro en la app (incluida en el pack completo) y guarda tu progreso:
menopausia-equilibrada.vercel.app

Tu primera semana

0 nada · 1 leve · 2 media · 3 fuerte · FIG. 37

	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7
1.							
2.							
3.							

Plan de 30 días

paso a paso



Una tarea pequeña por día. Si te saltas uno, no pasa nada: retoma mañana. Marca la casilla al terminar. También en la app: menopausia-equilibrada.vercel.app/#plan30

SEMANA 1 · ENTENDER

CAP. 01–03

☐ 1 Lee la Parte I — PÁG. 6	☐ 2 ¿En qué etapa estoy? — PÁG. 7	☐ 3 Marca tu mapa de síntomas — PÁG. 12	☐ 4 Empieza tu diario de 7 días — PÁG. 55	☐ 5 Lee «Lo que no se ve» — CAP. 03	☐ 6 Anota antecedentes familiares — PÁG. 19	☐ 7 ¿Qué notaste esta semana? — DIARIO

SEMANA 2 · MEDIR

CAP. 04

☐ 8 Lee «Tu diario de síntomas» — CAP. 04	☐ 9 Suma tu sueño al diario — PÁG. 22	☐ 10 Cierra tu primera semana — PÁG. 55	☐ 11 Resume el diario en una hoja — PÁG. 24	☐ 12 Pide tu cita médica — CAP. 05	☐ 13 Camina 30 minutos — CAP. 07	☐ 14 Haz algo que disfrutes — CAP. 08

SEMANA 3 · CONSULTAR

CAP. 05–07

☐ 15 Lee «La consulta que mereces» — CAP. 05	☐ 16 Elige 5 preguntas del guion — PÁG. 26	☐ 17 Lee las opciones de tratamiento — CAP. 06	☐ 18 Anota tus dudas — PÁG. 34	☐ 19 Primera sesión de fuerza — PÁG. 36	☐ 20 Revisa tu plato — PÁG. 37	☐ 21 Prepara tu carpeta de consulta — CAP. 05

SEMANA 4 · CUIDARTE Y COMPARTIR

CAP. 07–09

☐ 22 Un cambio para dormir mejor — PÁG. 38	☐ 23 Segunda sesión de fuerza — PÁG. 36	☐ 24 Lee «La empatía empieza por ti» — CAP. 08	☐ 25 Repasa las señales de alarma — PÁG. 44	☐ 26 Habla con tu pareja o familia — PÁG. 46	☐ 27 ¿Lo hablarás en el trabajo? — PÁG. 49	☐ 28 Suma tus minutos de actividad — CAP. 07

DÍAS 29–30 · REVISAR

CAP. 10

☐ 29 Lee mitos y preguntas — CAP. 10	☐ 30 Elige tu próximo paso — PÁG. 55	MI NOTA PARA EL MES 2

SI TE SALTAS UN DÍA, RETOMA

CELEBRA CADA CASILLA

Referencia de actividad: 150 min semanales de actividad moderada y fuerza 2 días o más (OMS). Las páginas remiten a este manual.

Glosario *de la A a la Z*

Nombrar bien lo que te pasa es el primer paso para que te escuchen.

A

Amenorrea. Ausencia de regla. Sesenta días o más sin regla marcan la transición tardía.

C

Climaterio. Palabra muy usada en Latinoamérica para los años de transición alrededor de la menopausia.

D

Densitometría (DXA). Prueba de imagen que mide la densidad de los huesos.

E

Estrógenos. Hormonas producidas sobre todo por los ovarios. Su descenso explica muchos síntomas.

Estrógeno vaginal. Tratamiento local (crema, óvulo o anillo) para el síndrome genitourinario.

F

FSH. Hormona foliculoestimulante. Sube en la transición; después de los 45 no se usa para diagnosticar.

Fezolinetant. Fármaco no hormonal para calores moderados o intensos, aprobado por la FDA en 2023.

H

Hipotálamo. Zona del cerebro que regula la temperatura; más sensible cuando bajan los estrógenos.

M

Menopausia. La última regla, confirmada tras 12 meses seguidos sin menstruación.

Menopausia prematura. La que ocurre antes de los 40 años.

Menopausia temprana. La que ocurre entre los 40 y los 44 años.

Menopausia quirúrgica. La que se produce al extirpar ambos ovarios.

O

Osteoporosis. Huesos más frágiles y con más riesgo de fractura.

P

Perimenopausia. Los años de transición con ciclos irregulares; termina un año después de la última regla.

Posmenopausia. Todo el tiempo después de la última regla.

Progestágeno. Hormona que se suma al estrógeno en mujeres con útero para proteger su revestimiento.

S

SGM. Síndrome genitourinario de la menopausia: sequedad, ardor, dolor en las relaciones, urgencia o infecciones urinarias.

Síntomas vasomotores. Calores (sofocos) y sudores nocturnos.

STRAW+10. Consenso internacional que define las etapas del envejecimiento reproductivo.

T

TCC. Terapia cognitivo-conductual. Tiene evidencia para los calores y ayuda con el sueño y el ánimo.

THM. Terapia hormonal de la menopausia: estrógeno, solo o con progestágeno, por distintas vías.

Definiciones basadas en OMS (2024), STRAW+10 (Harlow et al., 2012), NICE NG23 y The Menopause Society (2020, 2022, 2023). Fezolinetant: revisión PMC12401328 (aprobación FDA, 12 may. 2023).

Fuentes *con datos*

Por orden alfabético. Junto a cada fuente, las páginas donde se usa. Enlaces consultados en octubre de 2026.

AAFP (sobre USPSTF). Task Force Recommends Screening Adults for Hypertension. 20 may. 2021. www.aafp.org/about/news/20210520uspstfhype… **Págs. 17, 19**

AAFP (sobre USPSTF). USPSTF Lowers Screening Age for Prediabetes, Type 2 Diabetes. 8 sep. 2021. www.aafp.org/news/health-of-the-public/202… **Págs. 17, 19**

American Academy of Neurology. Perimenopause temporarily affects learning (Neurology, 2009). 25 may. 2009. www.aan.com/PressRoom/Home/PressRelease/736 **Págs. 14**

American College of Cardiology. Menopause Transition and Cardiovascular Disease Risk: AHA Scientific Statement (El Khoudary et al., 2020) — Ten points to remember. 10 dic. 2020. www.acc.org/Latest-in-Cardiology/ten-point… **Págs. 12, 15, 17, 19, 35, 53**

Australian Journal of General Practice (RACGP), basada en la guía internacional ESHRE/ASRM/CREWHIRL/IMS 2024. Premature ovarian insufficiency: diagnosis and management. abr. 2026. www1.racgp.org.au/ajgp/2026/april/prematur… **Págs. 9**

Avis et al., JAMA Internal Medicine. Duration of menopausal vasomotor symptoms over the menopause transition (SWAN). 2015. jamanetwork.com/journals/jamainternalmedic… **Págs. 1, 11, 12, 46, 52, 54**

Breastcancer.org / The Menopause Society. NAMS Releases Statement on Non-Hormone Therapy for Hot Flashes, Night Sweats (2023 nonhormone therapy position statement). 28 jun. 2023. www.breastcancer.org/research-news/non-hor… **Págs. 29, 33, 38, 42, 53, 54, 57**

CDC. Women and Heart Disease. 15 may. 2024. www.cdc.gov/heart-disease/about/women-and-… **Págs. 17**

CDC / NCHS. Characteristics of Women Ages 40–60 with Menopausal Symptoms: United States, 2025 (Data Brief n.º 575). oct. 2026. www.cdc.gov/nchs/products/databriefs/db575… **Págs. 11**

CIPD. Menopause in the workplace: employee experiences (y nota de prensa «CIPD calls for increased employer support»). 4 oct. 2023. www.cipd.org/uk/about/news/cipd-calls-incr… **Págs. 48, 49, 50**

EMAS (European Menopause and Andropause Society). Menopause Essentials 2026: Contraception. jul. 2026. emas-online.org/wp-content/uploads/2026/07… **Págs. 7, 10, 52, 54**

HSE (Health Service Executive, Irlanda). Postmenopausal bleeding. consultado oct. 2026. www2.hse.ie/conditions/postmenopausal-blee… **Págs. 10, 19, 24, 44, 54**

HSE (Irlanda). Who can and cannot take continuous combined HRT. consultado oct. 2026. www2.hse.ie/medicines/continuous-combined-… **Págs. 31**

Jean Hailes for Women's Health. Causes of menopause. modificado 22 oct. 2026. jeanhailes.org.au/health-a-z/menopause/cau… **Págs. 9**

King's College London. Overmedicalisation of menopause (serie Menopause, The Lancet 2024). 6 mar. 2024. www.kcl.ac.uk/news/overmedicalisation-of-m… **Págs. 7, 9, 13, 14, 18, 29, 31, 33, 38, 41, 42, 45, 48, 52, 53, 54**

Let's Talk Menopause. Highlights From the 2022 Hormone Therapy Position Statement of The Menopause Society. 2022. letstalkmenopause.org/our-articles/nams-20… **Págs. 30, 32, 53, 54, 57**

Manual MSD, edición profesional. Stages of Menopause (tabla adaptada de STRAW+10, Harlow et al., Menopause 2012). consultado oct. 2026. www.msdmanuals.com/professional/multimedia… **Págs. 7, 8, 57**

Manual MSD, edición profesional. Screening procedures in average-risk asymptomatic people (ACS, USPSTF, ACP). consultado oct. 2026. www.msdmanuals.com/professional/multimedia… **Págs. 19**

Mayo Clinic. Impact of Menopause Symptoms on Women in the Workplace (Faubion et al., Mayo Clinic Proceedings). 26 abr. 2023. newsnetwork.mayoclinic.org/?p=365470 **Págs. 48**

MDedge ObGyn. Chronic insomnia afflicts one in three perimenopausal women (SWAN, NAMS 2015). 3 oct. 2015. mdedge.com/content/chronic-insomnia-afflic… **Págs. 13**

NHS (Reino Unido). Menopause: symptoms. revisado 19 may. 2026. www.nhs.uk/conditions/menopause/symptoms/ **Págs. 8, 13, 14, 15**

NHS (Reino Unido). Insomnia. revisado 19 mar. 2024. www.nhs.uk/conditions/insomnia/ **Págs. 13, 38, 39**

NHS (Reino Unido). Types of hormone replacement therapy (HRT). consultado oct. 2026. www.nhs.uk/medicines/hormone-replacement-t… **Págs. 29, 30, 31, 32**

NHS (Reino Unido). Vaginal dryness. consultado oct. 2026. www.nhs.uk/conditions/vaginal-dryness/ **Págs. 32**

NHS (Reino Unido). Osteoporosis — Prevention. consultado oct. 2026. www.nhs.uk/conditions/osteoporosis/prevent… **Págs. 35, 36, 37**

NHS England and NHS Improvement. Menopause for partners. s. f. www.england.nhs.uk/midlands/wp-content/upl… **Págs. 46**

NHS North Bristol Trust. Ask 3 Questions. consultado 26 oct. 2026. www.nbt.nhs.uk/patients-carers/coming-hosp… **Págs. 26**

NICE (Reino Unido). Menopause: diagnosis and management (NG23). 2015, act. 2019; consultado oct. 2026. www.nice.org.uk/guidance/ng23 **Págs. 8, 21, 24, 25, 26, 52, 54, 57**

nidirect (Irlanda del Norte). Bleeding between periods. 23 dic. 2024. www.nidirect.gov.uk/node/12608 **Págs. 44**

NIH, Oficina de Suplementos Dietéticos. Calcio: hoja informativa en español. rev. 19 sep. 2023. ods.od.nih.gov/factsheets/Calcium-DatosEnE… **Págs. 16, 37, 39**

NIH, Oficina de Suplementos Dietéticos. Vitamina D — Datos en español. rev. 8 nov. 2022. ods.od.nih.gov/factsheets/VitaminD-DatosEn… **Págs. 37**

Organización Mundial de la Salud. Menopause (nota descriptiva). 16 oct. 2024. www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/m… **Págs. 6, 7, 9, 12, 25, 38, 41, 43, 44, 45, 47, 52, 57**

Organización Mundial de la Salud. Physical activity. consultado oct. 2026. who.int/initiatives/behealthy/physical-act… **Págs. 15, 16, 35, 36, 39, 54, 56**

Organización Mundial de la Salud. Depression (nota descriptiva). 11 sep. 2026. www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/d… **Págs. 14, 18, 19, 44**

Palacios S. et al. (REDLINC), Menopause 13(4). Age at menopause in Latin America. 2006. repositorio.uchile.cl/handle/2250/164172 **Págs. 1, 7**

PubMed Central (PMC12401328). FDA approves Veozah (fezolinetant) for menopausal symptoms: a new nonhormonal option. 2025. pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12401328 **Págs. 33, 57**

ScienceDaily / Rush University Medical Center. Sleep problems in menopause (Kravitz et al., SWAN, Sleep 2008). 3 jul. 2008. www.sciencedaily.com/releases/2008/07/0807… **Págs. 13**

Shepherd et al., Health Expectations 19(5):1160–1168. Use of a question prompt list (AskShareKnow) in a family planning clinic — pilot study. 2016. pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5152736 **Págs. 20, 27**

Society for Women's Health Research (SWHR). Menopause Fact Sheet (cita Bonafide, State of Menopause Survey). feb. 2025. swhr.org/wp-content/uploads/2025/02/SWHR-W… **Págs. 3, 25, 48, 51**

The ASCO Post. Studies Find Estrogen Alone Protective, Estrogen Plus Progestin Detrimental in Postmenopausal Women (WHI, Chlebowski et al., JAMA 2020). 25 ene. 2020. ascopost.com/issues/january-25-2020/studie… **Págs. 31, 53**

The Menopause Charity. How to ask your GP for help. consultado 26 oct. 2026. themenopausecharity.org/?p=176 **Págs. 21, 24, 27, 28**

The Menopause Society. The 2020 genitourinary syndrome of menopause position statement. 2020. www.isswsh.org/images/content/2020-NAMS-GS… **Págs. 12, 32, 40, 43, 53, 57**

The Menopause Society, Menopause 29(7). The 2022 hormone therapy position statement of The North American Menopause Society. 2022. pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35797481/ **Págs. 29, 30, 32, 34, 43**

U.S. Preventive Services Task Force. Osteoporosis to Prevent Fractures: Screening. 14 ene. 2025. www.uspreventiveservicestaskforce.org/usps… **Págs. 16, 19**

U.S. Preventive Services Task Force. Breast Cancer: Screening — Clinician Summary. 30 abr. 2024. www.uspreventiveservicestaskforce.org/usps… **Págs. 19**

University College London. Women are 40% more likely to experience depression during the perimenopause (Badawy et al., Journal of Affective Disorders). 1 may. 2024. www.ucl.ac.uk/news/2024/may/women-are-40-m… **Págs. 14, 53**

University of Melbourne (Pursuit). Self-compassion may help women cope with menopausal symptoms. 29 jun. 2017. pursuit.unimelb.edu.au/articles/self-compa… **Págs. 41, 42**

University of Melbourne / Medical Xpress. Self-compassion helps to cope with symptoms of menopause (Brown, Bryant, Judd; 206 mujeres). 5 jun. 2014. medicalxpress.com/news/2014-06-self-compas… **Págs. 41**

Vanderbilt Health. Women: what you need to know about bone loss (cita a la National Osteoporosis Foundation). 5 ene. 2016 (mod. 2021). my.vanderbilthealth.com/women-what-you-nee… **Págs. 16**



Sobre las cifras. Las de EE. UU., Reino Unido o Europa se indican como tales. Los cálculos propios (sumas, promedios, porcentajes derivados) están marcados en su página.

Actualización. Las guías cambian. Si una fuente se actualiza, prevalece la versión más reciente y el criterio de tu profesional.

gracias



SIN MIEDO

CON FUENTES



CON CARIÑO

«Esto es una etapa de la vida, no el final de nada.»

Calores que interrumpen reuniones, noches en vela, cambios de ánimo, dudas sobre la terapia hormonal y conversaciones difíciles en casa y en el trabajo. **PAUSA** te explica qué le pasa a tu cuerpo con datos verificados, te prepara para tu consulta y te ayuda a compartir la responsabilidad con quienes te rodean.

DENTRO

- 60 páginas, 3 partes, 10 capítulos
- 10 herramientas para usar hoy
- Diario de síntomas de 4 semanas
- Guion para tu consulta
- Guiones para pareja, familia y trabajo
- Plan de 30 días y glosario
- App que guarda tu progreso (pack completo)

PAUSA

EL MANUAL DE LA MENOPAUSIA · EDICIÓN 2026 · DISIERTECH

Este libro informa y acompaña; no sustituye la consulta con un profesional de salud. Imágenes generadas con IA con fines ilustrativos.
menopausia-equilibrada.vercel.app